蓝天妈咪护盾

——产后抑郁症保险





上海立信会计金融学院

SHANGHAI LIXIN UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE

第十五届中国风险管理与精算论坛

申

报

书

项目名称：“蓝天妈咪护盾”——产后抑郁症保险

团队成员：徐子茹、陈洋、于佳卉

指导老师：刘慧、张蕙

摘　要

近年来，随着二胎政策的落地和三孩政策的全面开放，在积极应对人口老龄化问题的同时，女性生育及其孕产期疾病也得到全社会的广泛关注。作为常见孕产期疾病，我国产妇人群产后抑郁症总检出率高达 15%。《中国妇女发展纲要（2011－2020）》《“健康中国 2030”规划纲要》等文件中都要求进一步关注孕产妇的心理健康状况。

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险着重于关注心理健康问题，为孕产妇提供保险产品和相关服务。在保险市场的基础上，对该类型保险产品从分析其可保性到保险产品内容进行设计。对于该产品可能存在的风险进行管理控制，并基于产品特点设计推广营销方式，最后对产品的未来发展作出规划。本文从保险层面就产后抑郁症此类心理疾病着笔，是心理疾病承保的初步探索，试图补充国内精神心理健康类保险产品和相关服务的空缺，为国内保险在心理健康领域的发展提供一份思路。

关键词：女性生育；产后抑郁症；保险

目　录

一、项目概述 1
（一）项目背景 1
（二）项目目的及意义 2
（三）国内外研究现状 2
二、需求分析 3
（一）常见医疗保险对产后抑郁症的针对性低 4
（二）国内市场对心理疾病承保存在缺位 5
（三）一定数量且长期存在的客户需求 6
三、可保性分析 8
（一）现有保险产品的有益探索 8
（二）满足可保风险的条件 8
（三）产后后抑郁保险的可持续性 10
四、保险产品设计 11
（一）产品基本信息 11
（二）保险责任 12
（三）责任免除 12
（四）配套服务 13
（五）投保流程 13
（六）理赔流程 13
（七）成本结构 15
（八）收入来源 15
五、产品定价研究 15
（一）影响因素 15
（二）定价方法 19
六、风险控制 19
（一）道德风险 19
（二）逆选择风险 19

（三）动态风险 20
（四）基差风险 20
（五）创新风险 20
七、推广与营销 21
（一）微信公众号宣传 21
（二）与妇联合作宣传 22
（三）广告营销 22
八、发展与展望 23
（一）开拓个险，提供更加个性化产品 23
（二）将医保账户增设为个险的保费缴纳渠道 23
（三）将男性列入可参保人群范围 23
（四）细化风险因素，逐步精细风险控制技术 24
九、保险创新 24
（一）心理疾病保险领域初探索 24
（二）购买形式多样 25
（三）“保障+服务”商业模式 25
（四）在个险的基础上增加医保账户作为保费缴纳新渠道 26
参考文献 27
附录 29
附录 1：产后抑郁症保险市场意愿调查 29
附录 2：“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症团体保险条款 41

一、项目概述

（一）项目背景

人口问题是一个国家发展的重要因素，近年国家相继出台“二胎政策”和“三孩政策”以应对人口老龄化问题，女性的生育问题得到全社会的广泛关注。同时随着社会经济的飞速发展和科技水平的进步，人们生活节奏越来越快，部分心理疾病日益凸显。结合上述双重因素，孕产妇的心理健康问题成为亟待研究解决的要点。

产后抑郁症的概念，最早在 1968 年由精神病学专家布莱斯·皮特提出。典型的产后抑郁症通常发生在产后 6 周内，可在 3-6 个月自行恢复，但严重的也可持续 1-2 年，再次妊娠则有 20%-30%的复发率[1]。全球不同国家地区产后抑郁症的患病率在 10%-20%之间，刘丁玮（2019）等人在一项包含 38357 例孕妇的实验研究中通过 Meta 分析得出中国产妇人群产后抑郁症总检出率为 15%[2]。由此可见，我国产妇的产后抑郁症检出率较高。

作为一种心理疾病，产后抑郁不仅危害产妇的身心健康，也会导致配偶情绪低落，并增加婴儿认知功能障碍、语言障碍、行为问题等风险，甚至会出现产妇自杀、残害婴儿等极端行为[3]。但此类疾病往往会被沉浸在获得新生儿喜悦中的亲友们忽视，《2022 国民抑郁症蓝皮书》中调查显示,有 63%的女性曾罹患产后抑郁,其中 40%的患者家人对产后抑郁患者处于漠视状态，13%的家属认为她们是在矫情，甚至还会讽刺。

就产后抑郁症的治疗费用而言，存在可报销药物范围有限、医药费用报销不全面的问题。同时，产后抑郁症或造成间接经济损失，如患者暂停工作疗养、雇佣保姆等的相关费用支出，使得孕产妇患病后的花销费用较高。目前，越来越多的人们注意到了产后抑郁症对于女性身心健康、家庭和谐乃至人口发展问题的影响，女性的产后抑郁症问题亟待社会保障。国家卫生健康委办公厅发布的《探索抑郁症防治特色服务工作方案》中提出，要加大对青少年、孕产妇、老年人群、高压职业人群等抑郁症防治重点人群干预力度。在《中国妇女发展纲要（2011－2020）》《“健康中国 2030”规划纲要》等文件中也要求进一步关注孕产妇的心理健康状况。东莞市政协委员黄容弟也曾建议要健全孕产妇心理卫生保健工

作体系，强化产后抑郁症的筛查干预[3]。

保险作为一种规避风险的手段，在心理健康领域同样能够发挥保障和补偿作用，全国人大代表方燕曾提出建议：“将妇女产后抑郁症的心理评估费用、心理治疗康复费用、产后恢复费用纳入生育保险待遇，参加生育保险的人员在协议服务机构发生的该项费用，由生育保险基金支付。”故团队打造“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险，为孕产妇提供保险产品，同时增加预防和就诊等配套服务，试图补充国内精神心理健康类保险产品和相关服务的空缺，为国内保险在心理健康领域的发展提供一份思路。

（二）项目目的及意义

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险是一款补充医疗保险。凡机关、团体、企事业单位的在职女性职工，在参加当地城镇职工基本医疗保险后，均可作为被保险人，由其所在单位作为投保人投保本保险。本产品旨在通过提供保险保障和增值服务，为女性生产的心理健康问题提供合理保障，满足女性在此时期的各种需求，从而维系家庭幸福和社会稳定。

产后抑郁症保险能一定程度上消解女性乃至整个家庭在生育健康方面的顾虑，为家庭提供经济保障。我国目前人口出生率连续三年跌破 1%，新生儿数量急剧下降，老龄化等问题日益突出。本产品的推出对于缓解社会老龄化、少子化等问题具有重大的意义。

产后抑郁症保险在顺应时代人口发展政策的前提下，提高家庭和社会对于女性生育心理健康状况的关注程度，合理利用保险的给付性为女性因患产后抑郁症造成的医疗经济损失提供保障，积极响应国家对于建立健全社会保障体系的号召，提升社会保障服务质量，弥补社会基本保障在女性生育问题方面的不足，提高女性在妊娠期及产后的幸福感，与社会共同守护女性健康的一片蓝天。

（三）国内外研究现状

除了少数保险公司的高端医疗产品有一定的精神疾病额度外，目前我国国内市面上心理健康类保险仍然较少。但政策上，国家已经意识到了心理健康保险发展的必然性，部分地区将心理治疗费用纳入了医保。例如广东省医保局发布的《关于印发“心理治疗”诊疗项目医保支付标准的通知》中提出，2021 年 8 月正式

开始报销心理治疗项目，把心理咨询纳入普通门诊。江苏省紧跟其后，自 2022 年 11 月起把心理治疗项目纳入基本医保支付范围，并全省统一执行。

在国外市场中，目前已经有上市的精神健康医疗公司，比如 Life Stance 就与多个保险公司建立了紧密的合作关系，同时这些精神健康医疗公司的大部分收入都来自于保险公司。例如根据图 1 Life Stance 的最新财报显示，其 2022 年商业保险的收入为 7.76 亿元，占业务总收入的 90.32%。2020 年伯克希尔·哈撒韦的全球再保险子公司 Gen Re 计划开发一款用于管理精神健康问题的保险产品。由此可见，心理健康层面的保险发展前景广阔，且对于社会稳定发展有重要意义。



图 1：Life Stance 医疗公司财报部分数据

董秉栋主张增值服务可以降低保险公司承保风险，带动保险保障内容的多元化发展[4]。鉴于是产后抑郁症保险的初步探索，在“保险+服务”的保险创新理念下，我们认为疾病干预和前期预防对控制保险赔付率有着重要作用。Silje Marie Haga 研究团队在 2013 年构建了一个完全自动化的网络干预平台 Mamma Mia，研究结果显示该网络干预平台在患产后抑郁症的女性中的接受度较高，具备较好的可行性[5]。在国内，随着微信用户的增多，有研究者通过向产妇推送微信公众号文章来实现健康保健、心理调适相关信息的传递，以改善产后抑郁症[6]。由此可见，国内外对于产后抑郁症的筛查、治疗等研究越来越全面，为产后抑郁症保险的设计推广提供坚实的理论基础。

二、需求分析

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险为团体补充医疗保险。通过“保险+服务”的商业模式，鼓励各单位企业为其全体女性职工投保，为员工在保险期间内可能面临的生育过程中提供精神和物质保障，提高企业员工福利，满足将产后抑郁症

的风险全部或部分进行转移的需要。

（一）常见医疗保险对产后抑郁症的针对性低

在社会各种心理疾病日益严重的情况下，保险公司由国内目前的治疗情况来看，孕产妇在确诊并治疗产后抑郁症的花销较大。产后抑郁症作为一种心理疾病，其治疗费用主要由心理咨询费和药物治疗费两部分组成。以上海职工基本医疗保险为例，就保险比例而言，仍有 20%-30%的医疗费用需要患者自行承担，就报销覆盖药物而言，适用于治疗产后抑郁症的药物数量较少。同时，百万医疗作为畅销保险产品在近几年中出现在人们视线里。以中国人寿保险公司旗下的百万医疗产品为例，其在保险条款中对一般医疗保险金设立了 10000 元的免赔额，同时因产后抑郁症因不在其 120 种重大疾病之列，无法从 120 种重大疾病医疗保险金此项保险责任中获赔，故想要通过购买百万医疗产品从而规避减少产后抑郁症所带来的经济损失并不可行。

表 1：上海地区产后抑郁症报销情况统计

<table>
<tr><td colspan="6">报销比例
（职工基本医疗保险）</td><td colspan="2">报销覆盖药物</td></tr>
<tr><td colspan="4">门诊</td><td colspan="2">住院</td><td rowspan="2">药物类型</td><td rowspan="2">药物名称</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自负段标准</td><td colspan="3">共负段报销比例</td><td rowspan="2">住院起付标准</td><td rowspan="2">报销比例</td></tr>
<tr><td>一级医院</td><td>二级医院</td><td>三级医院</td><td>非选择性单胺重摄取抑制剂</td><td>阿米替林、丙米嗪、多塞平、氯米帕明、马普替林</td></tr>
<tr><td>500元</td><td>80%</td><td>75%</td><td>70%</td><td>1500元</td><td>85%</td><td>选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂</td><td>帕罗西汀、艾司西酞普兰（10%）、氟西汀、氟伏沙明、舍曲林、西酞普兰</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：药物部分后标记“10%”的药品，由参保人员先自负 10%比例现金，其</td><td>其他抗抑郁药</td><td>米氮平、文拉法辛、阿戈美拉汀、度洛西汀、米安色林、米那普仑、曲唑酮、瑞波西汀</td></tr>
</table>

余费用再按本市基本医疗保险规定支付。剩余药品按照本市基本医疗保险规定支付。	协议期内谈判药品	**盐酸氟西汀口服液** 62.80 元(70ml:0.28g/瓶) (协议有效期 2024.1.1-2025.12.31) **盐酸曲唑酮缓释片** 3.74 元(75mg/片)； 6.36 元(150mg/片)(10%) (协议有效期 2023.3.1- 2024.12.31) **琥珀酸地文拉法辛缓释片** 6.72 元(50mg/片(按 C16H25NO2 计))(10%) (协议有效期 2024.1.1-2025.12.31)
	竞价药品部分	**草酸艾司西酞普兰口服液** 3.18 元 (按 C_{20} $H_{21}FN_2O$ 计:5ml:5mg/瓶)； 5.40 元(按 C_{20} $H_{21}FN_2O$ 计:10ml:10mg/瓶)； 36.19 元(按 C_{20} $H_{21}FN_2O$ 计:120ml:120mg/瓶) (协议有效期 2024.1.1-2025.12.31) **盐酸安非他酮缓释片(Ⅱ)** 4.45 元(150mg/片)； 7.57 元(300mg/片) (10%) (协议有效期 2023.3.1-2024.12.31)
	非药物	暂无

资料来源：上海市医保局

（二）国内市场对心理疾病承保存在缺位

目前我国正处于经济快速转型期，信息化、网络化加快了人们工作生活的脚步，由个体心理问题引发的社会问题日益显露，相比与躯体健康问题，社会心理健康问题呈现出更为紧迫的局势。但目前针对心理疾病的保险市场仍然处于空缺状态，保险公司急需深化保险供给改革，丰富心理疾病保险的产品种类，升级相关服务水平[7]。

目前国内保险公司的保险产品在寿险、健康险和意外险等领域的发展已经完善，社会发展多元化的趋势使得保险公司对于精细化的保险产品需求增大。因此，“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险能够满足保险公司对于精细化保险产品的需求，拓展保险公司的业务范围，属于保险的一类创新探索，能够开拓保险公司对心理疾病进行承保的新局面。

保险行业作为经营风险的服务行业，兼顾社会责任，彰显人文关怀有利于保险公司树立正面的社会形象，更好地宣传保险产品[8]。“蓝天妈咪护盾”产后抑

郁症保险的推广能够让保险公司对公众展示其对社会责任的承担，从而满足保险公司提升其社会形象的需求。

同时孕产妇的生产过程中涉及到的风险也不止产后抑郁这一个方面，产后抑郁险推广的同时也能够为其他险种的销售提供流量群体，增加其他产品的客源，让保险公司实现更多的盈利，实现双赢的效果。

（三）一定数量且长期存在的客户需求

据国家统计局的统计资料显示，目前我国每年的出生人口总数在 900 万左右，而我国产妇人群产后抑郁症的检出率约为 15%，由此可以粗略算出我国每年产后抑郁症患者约有 135 万人，患者总体数量庞大。在国家鼓励生育的各项措施下，新生儿数量会逐步增加，每年应可超过 900 万，患者数量相应增加，产后抑郁症保险的潜在客户需求大。

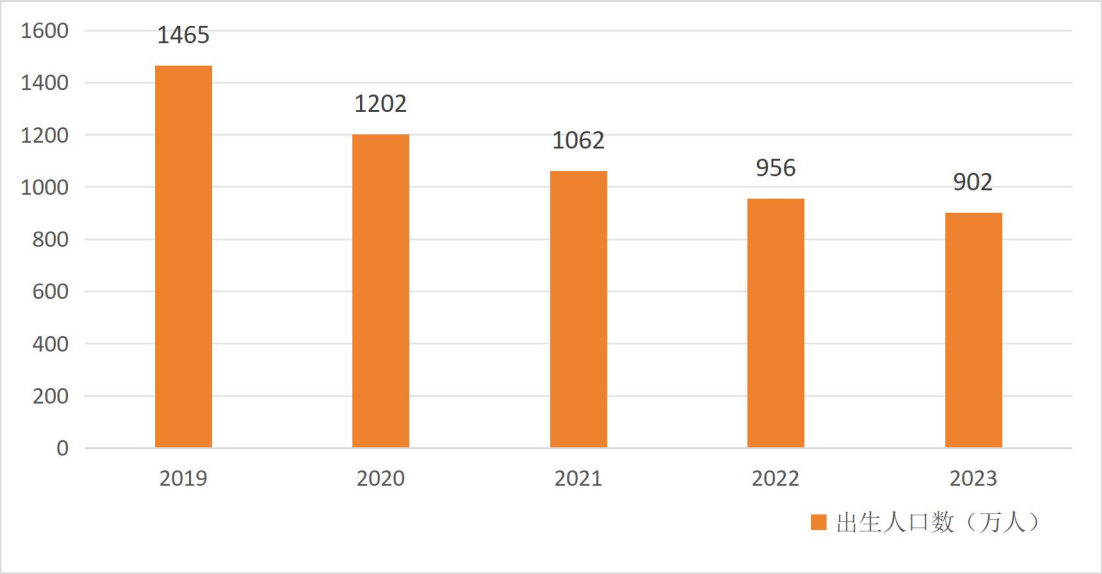


图 2：2019-2023 年我国出生人口统计

资料来源：国家统计局

目前人们通过购买保险来转移风险的意识有所提高。根据图 3 艾瑞咨询的调查资料显示，在购买过商业保险的人群中，80、90 后群体的占比已超过 75%。没有购买过商业保险但资金允许背景下有意愿购买商业保险的群体中，80、90 后人群占比也达到 70%以上。80、90 后群体已然成为目前保险消费的主力军。由此可见，保险作为可以迎合居民多样化风险管理需求的优良投资品，其抵御风险的优越性被越来越多的目标用户肯定。同样随着目前三孩政策的放开，80、90 后群体也是社会生育的主力军，针对生育问题的投保需求也非常大。



图 3：保险实际购买力及潜在购买力在不同年龄层的分布

资料来源：艾瑞咨询（www.iresearch.com.cn）

保险服务层面，随着医疗水平的进步和人们生活观念的提升，人们对于孕产妇的关注不再仅仅停留在生产的那一刻，而是延长到了怀孕阶段、月子期和育儿期，还提出了“全生命周期服务”这一概念。然而，根据图 4 艾瑞咨询的调查显示，目前私立医院和月子会所等的服务费用昂贵，多数人还是选择家人的照顾，但又希望能够有专业性的指导。

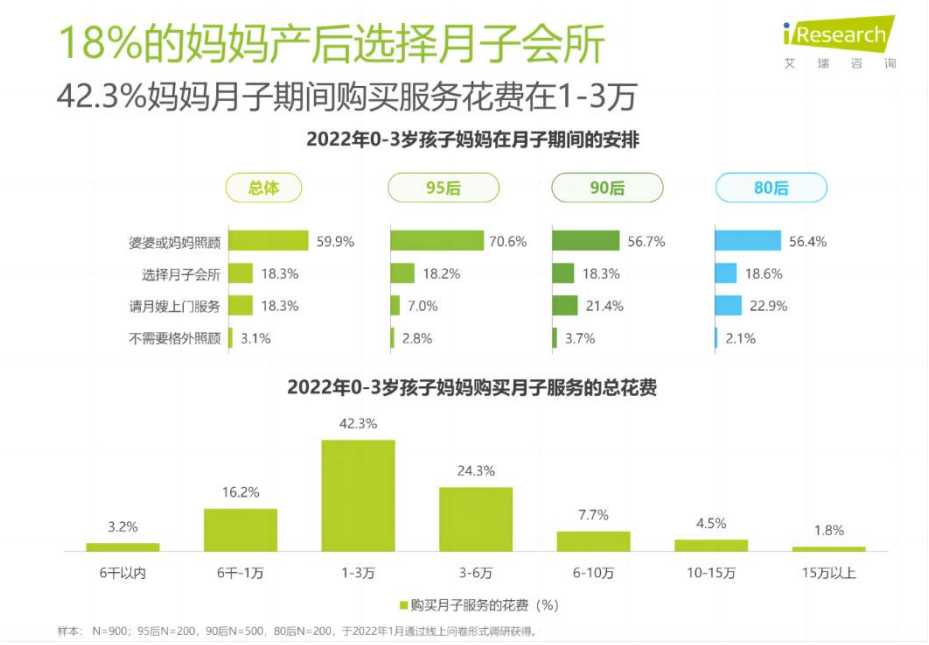


图 4：关于孕产妇对月子期服务的购买调查

资料来源：艾瑞咨询（www.iresearch.com.cn）

综上所述，产后抑郁症保险的客户群体数量庞大，同时产品在满足客户对于保险这一风险转移投资产品的需求的情况下，又可以为孕产妇客户提供高性价比的相关服务，让更多家庭能够享受到全方位的关怀和支持。因此产后抑郁症保险有充分的客户需求。

三、可保性分析

（一）现有保险产品的有益探索

商业保险在涵盖心理疾病和精神疾病方面一直相对保守，我国市场中极少数高端医疗保险产品对这两类疾病提供了额外的保障。以友邦传世无忧（2022）高端医疗保险为例，该产品在基础责任中特别设置了对精神疾病住院治疗费用的给付额度，为 3.5 万元；在可选部分中，对精神疾病门急诊费用的给付最高限额达到 8000 元。

这种针对心理和精神疾病的扩展保障明确展现了商业保险行业对于这一领域风险的认知和承担责任的愿望。友邦传世无忧（2022）高端医疗保险所提供的特殊保障，尽管在市场上属于少数，但其对精神疾病的理赔额度的设定充分体现了对这一健康领域的关注。市场上对于心理健康问题的重视日益增加，为我们的产品在市场上的推广和接受提供了积极的前景。这一趋势的存在为我们设计的“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险的可保性提供了坚实的支持。



图 5：友邦传世无忧（2022）高端医疗保险部分资料

资料来源：友邦传世无忧（2022）高端医疗保险

（二）满足可保风险的条件

1. 风险具有不确定性

符合保险人承保条件的风险应具备不确定性，即每一个具体单独的保险标的而言，保险当事人事先无法知道其是否发生损失、发生损失的时间和发生损失的程度如何。产后抑郁症作为女性在生育过程中所可能面临的心理疾病，妊娠妇女并无法在投保前后投保时预知在未来会确诊产后抑郁症，显然更无法准确计算其发病和确诊时间，以及因产后抑郁症所产生的损失。

2. 风险具有非故意性

首先产后抑郁症是多种因素的复杂反应。生产前后女性自身会面临生命体征变化的压力以及新角色转变等的心理压力。同时外界家庭和社会的保障支持也会影响产后抑郁症的发生。这些因素的复杂交织使得产后抑郁症的发生难以归因于个体的故意行为。其次被保险人没有患病预期。女性患产后抑郁症后的情绪往往是由期待和愉悦转为沮丧等消极情绪。这种非自愿的心理状态证明了产后抑郁症风险的非故意性。最后产后抑郁症有意外的负面后果。产后抑郁症会对患者的家庭造成伤害。同时产后抑郁症也会影响患者的职业生涯，甚至对整个社会的发展造成负担。但这种对个体、家庭和社会的负面影响不是患者故意追求的结果，而是一种意外和非自愿的后果。

3. 存在大量具有同质风险的保险标的

上文中对我国产后抑郁症患者数量已作粗略估计。庞大的患病群体和潜在的市场为“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品提供了可积累足够保险基金的基础。大数法则的运用在风险发生次数和损失值方面实现了相对小范围的波动，增加了产品的经济可行性。

4. 损失不能同时发生

风险可保性对损失值的方差有一定要求。损失不能同时发生，即损失值的方差不能过大。我国产后抑郁症发病概率在 15%-20%区间。同时 “蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品设计上采用团险和个险相结合的方式，通过将风险分散在大量被保险人群中，以平衡整体风险，确保了损失值方差的适度范围。

5. 损失是可以确定和测量的

在“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险合同中对可参保人群、保险责任、保险期限等做出了明确的规定。值得注意的是，为了确保产品在新特殊领域探索的稳定性和风险规避性，“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险仅作为一款补充医疗保险，不对自杀、身故进行承保或理赔。

当被保险人提出理赔需求时，被保险人的产后抑郁症确诊时间可以通过保单指定医院出具的医疗证明为准，其进行理赔申请的各项医疗费用可以向其就诊时保单指定医院开具的收费发票、医疗证明为核实标准。国内对产后抑郁的分类与诊断标准主要依据的是 ICD-10“精神与行为障碍分类-临床描述与诊断要点”及

美国 DSM-Ⅳ中有关抑郁发作和复发性抑郁障碍的相关内容和编码。

同时，保险人对被保险人所做出的保障是在风险造成后恢复到损失发生之前的状态，这需要被保险人的损失金额能够被货币衡量。显然，产后抑郁症患者的医疗成本、收入损失等损失都是可以通过合适的方式进行货币价值衡量。

（三）产后后抑郁保险的可持续性

1. 风险管理和资金储备

有效的风险管理机制和充足的资金储备是保障产后抑郁症保险可承保性持续性的基石。保险公司需要建立一套有效的风险管理机制，定期评估产后抑郁带来的各类风险，监控客户索赔的可能性和赔付水平，以确保对潜在风险的及时识别并根据实际情况制定相应的风险防范策略。同时，为了确保公司有足够的资金来面对潜在的高额索赔，保险公司需要合理规划和管理资金，避免出现因资金短缺而导致无法兑现保险承诺的风险。

2. 费率调整和产品改进

费率调整和产品改进是保险公司确保产后抑郁症保险可持续性的重要举措。保险公司需要定期评估产后抑郁症保险产品的费率水平，通过对市场数据和索赔统计进行深入分析，可以更准确地评估产后抑郁风险的实际情况，从而根据风险水平进行相应的费率调整，以确保其与风险情况相匹配，保证公司的盈利能力和产品的可持续性。

同时，通过与客户进行深入沟通和调研，保险公司应更贴近客户的实际需求和期望，有针对性地对产后抑郁症保险产品进行改进，包括但不限于产品条款的优化、理赔流程的简化、服务内容的增加等方面的改进。保险公司还需密切关注行业发展趋势和技术进步，及时引入新的科技手段和创新理念，为产后抑郁症保险产品赋予更多的附加价值和保障内容，提高其竞争力和吸引力，提升客户满意度和忠诚度，有助于拓展新的市场空间，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。

3. 市场监测和竞争分析

为保持产品的可承保性持续性，在市场中保持竞争力，保险公司需要密切关注市场动态和竞争对手的行动。用市场调研报告、消费者反馈和趋势预测等方式收集和分析相关数据，定期进行市场监测，了解客户的需求变化、市场趋势和竞

争对手的产品特点和价格策略，从而帮助保险公司及时调整自身的产品策略和市场定位，以满足不断变化的市场需求。

4. **客户服务和投诉处理**

保险公司应该建立高效的客户服务体系，如增添在线客服和建立专门的投诉处理机制，确保客户在购买保险、理赔申请或其他服务方面能够得到及时的支持和帮助，化解潜在的矛盾，保持良好的客户关系，增强客户对公司的信任感和满意度，树立公司的良好的品牌形象，吸引更多客户选择该公司的保险产品。

5. **法律法规遵从**

保险公司在产品设计和销售过程中必须严格遵守法律法规和监管要求，如合理公平地定价、客观真实地推广营销、保护客户隐私和及时明确地信息披露等。遵守适用的法律法规能够有效规范保险市场秩序，保护消费者权益，同时也有助于保险公司自身的可持续发展，促进行业的健康发展，实现长期可持续经营的目标。

6. **持续的市场推广和教育**

为了确保产后抑郁症保险的可承保性持续性，保险公司需要进行持续的市场推广和教育工作。这一过程不仅有助于提高公众对产后抑郁症保险的认知和理解，将产品信息传递给更广泛的受众群体。并且通过与专业机构、医疗机构等合作，保险公司还能够提供更深入、权威的信息支持，增加产品的可信度和吸引力。持续的市场推广和教育工作将有助于建立起公众对产后抑郁症保险的信任和认可，为产品的可承保性持续性奠定坚实基础，保险公司能够吸引更多潜在客户，促进产品的销售增长和市场份额提升。

四、保险产品设计

（一）产品基本信息

表 2：“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品基本信息

产品名称	“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险
产品类型	团体补充医疗保险
可参保人群	凡机关、团体、企事业单位的在职女性职工，在参加当地城镇职工基本医疗保险后，均可作为被保险人，由其所在单位作为投保人向本公司投保本保险。 其中参加本保险的参保人员须符合的基本条件为年龄范围在20（含）周岁—45（含）周岁无心理疾病病史、家族史的女性职工。
保险期间	一年

（二）保险责任

1.**产后抑郁症门诊医疗保险金**

在保险期间内，被保险人在等待期届满后在指定医院确诊罹患本合同约定的产后抑郁症，对于被保险人在指定医院的普通部中为了治疗上述产后抑郁症而实际支出的、合理且必要的门诊医疗费用，保险人在扣除本项保险责任约定的免赔额后，按照本项保险责任约定的给付比例，在本项保险责任约定的保险金额内支付产后抑郁症门诊医疗保险金。

2.**产后抑郁症住院医疗保险金**

在保险期间内，被保险人在等待期届满后在指定医院确诊罹患本合同约定的产后抑郁症，对于被保险人在指定医院的普通部中为了治疗上述产后抑郁症而实际支出的、合理且必要的住院医疗费用，保险人在扣除本项保险责任约定的免赔额后，按照本项保险责任约定的给付比例，在本项保险责任约定的保险金额内支付产后抑郁症住院医疗保险金。

（三）责任免除

（1）投保人对被保险人的故意伤害、故意杀害；

（2）被保险人曾患有心理疾病及精神疾病的；

（3）被保险人违反《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》条款；

（4）被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施、自杀(但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外)、故意自伤；

（5）等待期内被保险人确诊本合同约定的产后抑郁症；

（6）被保险人在本合同约定的指定医院的普通部之外产生的任何费用；

（7）被保险人斗殴、酗酒、主动吸食或注射毒品；

（8）被保险人因受国家管制药物的影响或未遵医嘱服用、涂用、注射药物；

（9）各种医疗鉴定、医疗意外和医疗事故；

（10）被保险人因产后抑郁症之外的原因身故；

（11）被保险人不符合入院标准、挂床住院或者应当出院但拒不出院（从医院确定出院之日起发生的一切医疗费用）；

（12）被保险人因患产后抑郁症所引起的财产损失；

（13）被保险人因患产后抑郁症对第三者造成的人身伤亡和财产损失；

（14）战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；

（15）核爆炸、核辐射或核污染

（四）配套服务

表 3：“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险配套服务

在保险期间内，被保险人可获得服务：	
孕前的专业医疗咨询	产检陪同服务
孕产期内 2 次专业心理疏导	孕产妇社群
孕产小课堂线上视频课	
若在保险期间内，被保险人确诊产后抑郁症，在上述服务基础上增加：	
就诊预约服务 2 次	康复后专业医师回访 2 次
从患者确诊日起半年内，其法定伴侣免费心理检测 1 次	

（五）投保流程

本产品投保可参照团体保险的基本流程。首先不以团购本产品为目的的团体可打电话保险公司或到保险公司官方网站咨询客服团体保险的价格。在有购买意愿后，其应按“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症团体保险相关要求递交资料，包括但不限于团体投保书、团体保险被保险人明细、投保/保全申请追溯声明书等。递交材料后公司等候保险公司审核，核保通过以后达成签约保险关系。

（六）理赔流程

1. 立案登记

在被保险人确诊罹患产后抑郁症后，被保险人应及时向保险公司报案，提出理赔申请。被保险人应履行应尽义务，在立案时向保险公司提供被保险人姓名、地址、保单号码等内容。保险公司根据报案内容预判该风险事故是否属于保险责任范畴、满足理赔条件。若符合条件，则进入理赔流程。

2. 收单

进入理赔流程后，被保险人应根据合同或额外约定向保险公司提供包括但不限于保险金给付申请书；保险金申请人、被保险人的有效身份证明；孕妇(健康/保健)手册、孕期检查报告、分娩的出院记录；新生儿的医学出生证明；就诊指定医院出具的支持索赔的全部账单、证明、信息和证据；保险金申请人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

3. 医疗评估与单证审核

在收单后，保险公司有权要求被保险人接受医学评估，以确认其诊断和治疗的必要性。而后保险内勤人员应立即进行单证的审核，确保保险单的有效性和有关单证的有效性。

4. 计算赔款

在确认了保险凭证和有关单证的有效性后，保险公司应根据被保险人提供的损失清单进行赔款计算。

（1）产后抑郁症门诊医疗保险金

赔款=（保险责任范围内的门诊医疗费用-免赔额）*约定的给付比例

（2）产后抑郁症住院医疗保险金

赔款=（保险责任范围内的住院医疗费用-免赔额）*约定的给付比例

5. 赔付结案

保险人经过审核、定损、计算赔款，就赔付金额与被保险人或受益人达成协议后，应及时给付保险金。若被保险人对保险金给付金额有任何异议，应协商处理。

6. 跟进和反馈

保险公司会对理赔流程进行跟进，以确保赔付过程顺利进行并满足被保人的需求。同时，被保人也可以提供对理赔流程的反馈，以帮助保险公司改进服务质

量。

（七）成本结构

1.**业务支出**

产后抑郁症保险的核心职能是为被保险人提供全面的医疗费用保障，覆盖产后抑郁症门诊医疗费用和住院费用的给付。为实现更全面的服务，保险公司常与医疗机构、心理咨询机构等建立战略合作，以确保客户能够获得专业的增值服务。

2.**推广费用**

产后抑郁症保险的推广和销售需要通过巧妙的渠道进行，以提高产品的市场占有率和知名度。广告宣传、市场推广等费用的投入是确保产品被广泛认知的必要手段。在这方面，保险公司可充分利用社交媒体和医疗专业网站等渠道，通过定向推广吸引目标受众，提高产品的市场份额。

3.**管理费用**

管理费用覆盖了保险公司内部运营的各个方面，包括人力资源、办公设备、信息技术系统等。对于“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品，额外的培训和支持团队是确保服务被保险人的重要组成部分。

优质的客户服务同样是心理健康保险的关键要素。为此，保险公司需建立专业的客服团队，以高效回答客户疑问、快速处理理赔申请，并提供心理健康咨询服务。这些服务不仅有助于满足客户需求，还能提高客户满意度和品牌忠诚度。

（八）收入来源

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品的主要收入构成包括保费收入和投资收益两个关键部分。在保费方面，保险公司与有投保意向的事企业单位签订保单，从中收取团险保费。除了保费收入外，投资收益是公司另一个重要的经济来源。公司将“蓝天妈咪护盾”保险产品所筹集的一部分保费用于巧妙的投资，旨在增加资金规模，并以期望获得更高的回报率。

五、产品定价研究

（一）影响因素

风险保费的定价基础是风险概率*平均风险损失金额，而损失金额则可通过分布函数来建立损失模型。即风险概率大小或者损失金额大小都直接影响风险保费定价。对于“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险可能影响的定价因子基本包含两大方面因素：环境因素和个体因素。

1. 环境因素对定价的影响

环境因素主要指不同地区对产后抑郁症保险保费的影响。不同地区的不同的社会支持体系（如医疗政策的差异性）、当地文化不同等使得不同地区的产后抑郁症风险和治疗费用存在差异。

表 4：上海市产后抑郁症住院费用

地区	平均住院费用（损失费用：元）	住院发生概率（损失概率%）	个人支出占比（%）
上海	15935.7	10.9	20.69

资料来源：上海市产后抑郁现况调查[9]

以上海为例：

平均住院费用（损失费用）为 15935.7 元，表示在治疗产后抑郁时，平均每位产妇可能需要支付该费用。

住院发生概率（损失概率）为 10.9%，表示在上海市产妇中，大约有 10.9%的人可能会患上产后抑郁。

个人支出占比为 20.69%，表示在治疗产后抑郁时，产妇个人需要承担的费用占其总费用的比例[10]。

2. 个体因素对定价的影响

个体因素主要包括被保险人的职业、年龄、学历。

（1）职业

不同职业人群面临的职业压力不同。CareerCast 以 11 项指标作为考察标准，并给予每项指标一定的比例，包括出差频率、收入增长潜力、竞争程度、体力要求、实际的工作环境、危险指数等，将不同职业压力进行预测和量化。

表 5：CareerCast 职业压力评分排行节选

职业	平均收入	工作环境	压力	预计增幅
诊断医学超声医师	$71410	37	1	25
合规官	$67870	22	2	166
发型师	$25850	59	3	72
听觉矫正专家	$75920	68	4	29
大学教授	$76000	1	5	54
医疗记录技术员	$39180	12	6	195
珠宝商	$37960	14	7	18
运筹学分析师	$81390	47	8	18
药房技师	$31750	52	9	19
按摩治疗室	$39990	27	10	10

资料来源：Career Cast《2019 年职业评分报告》

研究表明，职业压力对产后抑郁症患病率具有显著的影响，尤其是在女性生育后因长时间不工作所面临的职业竞争性等因素下，女性更容易感受到工作再参与过程中的焦虑，从而增加产后抑郁症的患病风险。

高压职场竞争的激烈性使她们感到更大的不安全感，担忧自身在职业生涯中的位置和发展前景，从而导致心理上的负担增加。同时，生育后女性在职场中可能面临来自同事和管理层的期望压力，尤其是在应对工作与家庭的双重责任时，加剧了她们的焦虑感。

（2）年龄

表 6：年龄对产后抑郁症患病率的影响

年龄组	产后抑郁症发病人数
≤22 岁	7
23-29 岁	58
30-34 岁	46
≥35 岁	10

资料来源：深圳市福田中心区孕产妇产后抑郁症发病现状及发病因素分析[11]

以深圳市为例，其产后抑郁症的发病率为 9.45%，即在 1280 例产妇中，有 121 例被确诊为抑郁症。进一步分析不同年龄组的产后抑郁症发病情况表明，23-34 岁为产后抑郁症的高发年龄段。

（3）学历

表 7：学历对产后抑郁症患病率的影响

学历层次	抑郁组（例）	非抑郁组（例）	发生率（%）
小学	10	41	19.61
初高中	53	207	20.38
大学	40	125	24.24
研究生及以上	9	16	36.00

资料来源：深圳市福田中心区孕产妇产后抑郁症发病现状及发病因素分析[11]

同以深圳市为例，根据数据分析结果发现学历较高，特别是研究生及以上学历的产妇，出现产后抑郁症的机率要比其他学历层次更高。

在小学学历层次的产妇中，有 10 例被确诊为抑郁症，41 例未被确诊为抑郁症，发生率为 19.61%。

在初高中学历层次的产妇中，有 53 例被确诊为抑郁症，207 例未被确诊为抑郁症，发生率为 20.38%。

在大学学历层次的产妇中，有 40 例被确诊为抑郁症，125 例未被确诊为抑

郁症，发生率为 24.24%。

在研究生及以上学历层次的产妇中，有 9 例被确诊为抑郁症，16 例未被确诊为抑郁症，发生率为 36.00%。

（二）定价方法

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险采用经验频数法，即根据被保险人年度产后抑郁治疗费用的发生率和费用，将超过设定的起付线但低于赔付限额的医疗费用进行汇总，除以基线参保人数，再考虑医疗费用增加系数和保险因子等即可实现定价，公式表达为：

$$P(x) = \frac{C_{(M_1,M_2)} - N_{(M_1,M_2)} \times M_1}{N'} \times \alpha \times \gamma \qquad (1\text{-}1)$$

其中，M_1表示起付线，M_2为赔付上限，$C_{(M_1,M_2)}$表示所有风险事件的总索赔额，$N_{(M_1,M_2)}$为起付线以上限额以下人数，N’为基线期参保人数，α为赔付比例，γ为医疗费用增长系数等调整系数。

根据经验频数法的内在逻辑，可计算“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保障范围内总的医疗费用，由此得到总的预期赔付金额，除以预估参保人数再考虑调整系数，即可实现“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险的定价。

六、风险控制

（一）道德风险

道德风险是指在信息不对称条件下，不确定或不完全合同使得负有责任的经济行为主体不承担其行动的全部后果，在最大化自身效用的同时,做出不利于他人行动的现象。

由于心理疾病相较生理疾病，躯体化症状表现多样，确诊标准模糊，在健康告知的过程中，容易出现投保人或被保险人故意隐瞒的现象。为了尽量减少道德风险的存在，在产品推出初期，仅以团险的形式供各企事业单位为其员工购买，将道德风险在产品对心理承保领域探索初期降低至可控范围内。

（二）逆选择风险

逆向选择是指由于交易双方信息不对称和市场价格下降产生的劣质品驱逐优质品,进而出现市场交易产品平均质量下降的现象，即次标准体或拒保体的投保人群保险购买欲望和意图更为强烈。

“蓝天妈咪护盾”此款产品在以团险形式出售。这种大规模参与可以使个体的风险差异会被平均化，有效地分散风险。同时在团体保险中，个体无法单独选择保险计划或调整保险金额，防止个体根据自身风险选择高保额的保险，从而降低了逆向选择的可能性。

此外，“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品对给付金额设置了免赔额和给付比例，既能通过设立免赔额起到减少保险公司理赔人员工作量、降低保险公司经营成本的目的，又能降低遭受风险损失可能性大的投保人带来的逆选择风险。

（三）动态风险

产后抑郁症保险面临的主要动态风险是，在长期发展中，我国医保报销比例存在变动的可能性。医保政策可能会因社会经济因素、公共需求和财务压力等因素而进行调整，这对保险人所要面对的给付金额有一定影响。保险人应及时了解相关政策导向与变动，对定期审查保险合同，就涉及的合同相关条款和承保条件进行及时调整，根据新的政策做出相应的决策，包括但不限于给付比例、限制和赔付标准等。

（四）基差风险

基差风险指被保险人在妊娠期及产后一年中确诊产后抑郁症实际所发生的损失与利用公式计算出的赔付额不能完全对应的风险。这种风险的存在使得部分被保险人在申请理赔后所获得的给付金额与其实际上因为产后抑郁症所遭受的损失有着较大出入。在费率厘定阶段，保险公司无法做到完全避免基差风险，但仍可以通过更密集、更细化地收集数据，制定更加合理的费率，将该风险发生概率降低。同时，在产品投入市场后，保险公司仍可以通过持续进行产品追踪，收集更多一线数据，在实践中不断丰富、修正和完善，逐步精确精算模型，使保险责任更准确，费率和赔付额更合理，在最大程度上减少基差风险。

（五）创新风险

对于心理疾病的承保问题，我国理论研究较少，对被保险人的疾病保障研究大多集中在传统狭义的生理疾病领域中，对于产后抑郁症保险创新研究更是少之又少。同时，由于心理疾病的患病因素复杂、患病症状多样，其诊断和治疗具有较大的主观性和复杂性，要求保险人有较高的核保技术和承保能力，故在现阶段市场中，并没有出现承保产后抑郁症的保险产品。

“蓝天妈咪护盾”此款产品作为心理疾病保险的前路开拓者，面临着较大的创新风险。针对上述问题，在产品落地过程中要确立明确的理赔标准和流程，与专业医疗机构合作以获得客观的诊断和治疗证据，确保被保险人的医疗证据是必要的、真实的。不可置否，尽管面对着一个完全空白的市场，“蓝天妈咪护盾”的产品创新对我国心理疾病承保的理论研究和实操有着巨大的意义。

七、推广与营销

（一）微信公众号宣传

随着互联网新媒体时代的全面到来，资讯传播覆盖面大幅提升，传播速度明显加快，利用互联网和社交媒体平台进行数字营销已经成为宣传途径中的主流，包括搜索引擎优化(SEO)、社交媒体广告、内容营销等。微信公众号相较于其他宣传途径，操作方便，节约成本传播速度更快，宣传效果更好，现已成为保险行业的重要宣传手段[12]。

“蓝天妈咪护盾”公众号板块设置清晰，其内容可分为六大板块：知识科普、专家访谈、真实经历分享、保险产品介绍、社群服务和妈咪树洞。

通过发布病症相关的科普推文和领域专家的专访记录，建立对产后抑郁症的正确认知，提高大众对其的重视性。真实经历分享的呈现使保险产品的功能更加可视化，使潜在的目标客户对“蓝天妈咪护盾”此款产后抑郁症保险产品有更加感性的认知。基于对病症的正确认知和对产品的直观感受，保险产品介绍功能为客户提供了一个能够十分详实地了解产品具体内容的窗口。

同时，通过微信公众号内容引流，建立社群，搭建起一个桥梁，将用户及潜在用户变成社群成员，形成有效的沟通交流渠道，保险人在群内对社群成员就产品问题进行个性化的服务和专业咨询，增强消费者的好感和对保险公司认可度，由此，为公司建立健康、可信赖的品牌形象。此外，公众号内设置了“妈咪树洞”，

体现了保险公司对此产品的创新初心与设计理念——给予妈妈们一份保障，建造一个妈妈们的避风港。脱下生活中成为人母的坚强外衣，在妈咪树洞中，任何用户都可以无条件向我们倾诉她们的烦恼及苦闷。

（二）与妇联合作宣传

《国务院关于实施健康中国行动的意见》中提出要维护全生命周期健康，实施妇幼健康促进行动。产后抑郁症在对母亲造成生理及心理上的伤害的同时，也会对婴幼儿造成母婴连接障碍等不良影响。全国妇联副主席、书记处第一书记黄晓薇指出，家庭是社会的细胞，家庭健康是全民健康的基础，而母亲在促进家庭健康中具有独特作用[13]。

全国妇联开展的“健康中国——母亲行动”为“蓝天妈咪护盾”产品提供了一个极为契合的宣传平台。保险公司可基于妇联的特殊性定位，与其建立健全畅通的利益表达和约束机制，搭建合作平台。通过资源共享、整合有效的信息来实现“单打独斗”无法完成的宣传推广目标，提升产品推广绩效[14]。例如，可开展以产后抑郁症为主题的讲座、研讨会、社区活动或健康咨询等公益性科普活动；发布信息手册，向公众宣传产后抑郁的重要性和影响，以及产后抑郁症保险的价值和益处；搭建社区义诊平台，邀请各地区妇产科和精神科专家医生，为女性居民提供产前产后问诊和心理疏导。这些活动有利于提高公众对产后抑郁症的认知度和保险产品的关注度，同时也能够促进大众对母婴健康的关注和重视。

（三）广告营销

1. 影视作品植入

美国全球品牌内容营销协会分会主席辛迪开来普斯提出，我们正从一个营销的“打扰时代”，进入一个“植入的时代”。相比于传统形式的广告，植入式广告更容易吸引观众的注意力[15]。通过将保险产品植入影视剧之中进行情景化演绎，用群众喜闻乐见的方式，充分展示本产品的独特优势，潜移默化地加强群众对于本产品的了解，向有潜在购买者介绍本保险的重要性和保障内容。例如，可在体现职场女性遭遇的生育风险与现实困境的热播剧《我是真的爱你》中，插入本保险产品的介绍，提高本保险的认知度和关注度[16]。

2. 自媒体营销和社交平台推广

自媒体和社交平台具有互动性、及时性和可见性的优势，可用于产品推广和广告宣传[17]。如今，短视频平台的用户基数大，发展潜力大，年龄分布广泛，尤其以具有较大消费力的年轻和中年群体为主，与“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险的受众群体较为吻合。故保险公司可在短视频社交平台投放广告进行宣传推广，以实现用户推广和销售的一体化。同时，也可联合知名博主进行保险产品的代言和推广，根据博主的粉丝群体的构成，对符合本保险产品定位的目标群体和潜在客户进行定向化宣传，并适时植入购买保险的链接，进一步挖掘客户群体。

八、发展与展望

（一）开拓个险，提供更加个性化产品

在产品开发初期，为较好控制道德风险和逆选择风险，同时降低初探心理承保领域的损失成本，保险团队仅向市场投放“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症团体保险。在团险的推出和实践中，加深对客户需求的精准定向和市场需求的精细把控，再适时开拓“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症个险。相较于团体保险，个险向客户提供更加个性化的服务选择，提高客户的服务体验感，做到“有保无险”，降低出险率，且为后续开拓新保费缴纳渠道打下基础。

（二）将医保账户增设为个险的保费缴纳渠道

当前，医保账户主要用于支付实际医疗费用，未能充分发挥其潜在功能。传统的保险支付方式通常采用固定的现金支付，对于购买保险的灵活性较差。同时，医保账户中的资金余额常常处于闲置状态，没有得到有效利用。

保险团队基于现状，将医保账户中的余额纳入个险保费缴纳渠道，允许投保个险的被保险人将医保账户余额用于缴纳“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险的保费。此举不仅提高了客户购买保险产品的便捷性，也能更有效地利用医保账户的闲置资金，激发更多人参与产后抑郁症保险，提高整体的保障水平。值得注意的是，为了避免客户利用此渠道对医保账户中的余额进行套现，若投保人申请保险退单，由医保账户缴纳的保费将原路返回至医保账户。

（三）将男性列入可参保人群范围

传统观念下，产后抑郁症主要被视为女性问题，故在“蓝天妈咪护盾”保险产品设计之初只将符合投保要求的女性列入参保范围。然而，由于亲职压力等原因，男性产后抑郁症的发病率为 10. 4%，产后 3 - 6 个月的发病率最高，达 25. 6%，故将男性纳入可参保人群范围，以更全面的视角提供产后抑郁症保险。这种转变不仅满足了男性在心理健康方面的需求，也推动了性别平等的理念，为更广泛的人群提供保障。

随着可参保人群的范围扩大，保险团队认为在购买个险的前提下，应允许男女双方的医保账户都可用于缴纳产后抑郁症保费。这种整合不仅有助于提高家庭整体的健康管理水平，也促使家庭成员提高对健康保险的参与度，增加了互助性和共同责任感。

（四）细化风险因素，逐步精细风险控制技术

目前社会对于产后抑郁症的风险因素了解较为有限，缺乏个性化的风险评估手段。未来将利用先进的技术手段，如大数据分析、人工智能等，对产后抑郁症的风险因素进行更为细致的研究。通过个性化的风险评估，保险公司能够更准确地识别被保险人的风险，采取更有针对性的风险控制措施，提高保险产品的精准度和适应性。

九、保险创新

（一）心理疾病保险领域初探索

目前我国的人身保险领域处于狭义的定义，侧重于身体健康。从社会文化看，我国对心理疾病仍存在一定程度的不重视甚至污名化[18]。从保险标的看，产后抑郁症此类心理疾病具有难归因、难定损的特殊性。从承保能力看，保险公司缺少同类型产品创新和承保经验。而作为一个特别需要关怀和保障的群体，产妇的心理健康风险备受关注，其心理健康风险的相关保障需要一个更加细致且专业化的服务。

保险团队通过构建自身理论框架，设计专门针对产后抑郁症问题的保险产品——“蓝天妈咪护盾”，为其符合承保条件的门诊费用、住院费用及身故费用进行给付，在一定程度上填补市场空白和研究缺口，具有一定创新性和实用性。“蓝

天妈咪护盾”产后抑郁症保险为心理疾病保险领域开辟了一条新的道路，对推动心理健康保险发展、保障心理疾病风险具有重要实践意义，对于推动整个健康保险行业朝着更全面、个性化和关注心理健康的方向发展具有积极的影响，对于整个社会的心理健康认知和支持体系的建设都具有积极的促进作用。

（二）购买形式多样

在产品推出初期，“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险仅以团险形式供客户购买，在实践中加深对心理保险领域的了解和把控度后，将在团险的基础上增加个险购买的选择。

2015 年 2 月中国保监会《促进团体保险健康发展有关问题的通知》对于团体保险投保限制进一步松绑，文中明确团体保险被保险人的最低限制由 5 人降低为 3 人，促进了我国团体保险的发展[19]。这种方式的优势在于规模效应，通常可以获得较为优惠的保费，并且能够更好地满足大批人群的共同需求。

而对于更注重个体需求的客户来说，个险提供了更多的选择和灵活性，此类人群可以根据自身健康、经济状况和需求自由进行选择不同程度的保险保障和定制个性化的增值服务。同时保险公司也可以根据个人的健康状况和风险因素进行定价，提供更精准的保障。

（三）“保障+服务”商业模式

1. 医疗费用全面保障

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品为被保险人提供的保险责任有产后抑郁症门诊医疗保险金和产后抑郁症住院医疗保险金，从小症状到大治疗，为产后抑郁症的全程治疗提供了全面保障。在保险条款中，明确了保障范围和理赔流程，确保客户在需要时能够及时获得帮助。

2. 配套增值服务创新

想要保险行业可持续健康发展，必须贯彻以人为本的发展理念，深度挖掘和探索客户需求，在提供保障的同时，保险团队与医疗机构、心理咨询机构、康复中心等合作，向被保险人提供了一系列增值服务[20]。例如，在线心理咨询服务、抑郁症筛查和预防服务、康复训练服务等。这些服务可以帮助患者更好地应对抑郁症，提高康复效果和生活质量。

通过以上“保障+服务”的创新模式，产后抑郁症保险可以为患者提供更全面、高效、便捷的保障和服务，帮助她们更好地应对抑郁症并提高生活质量。同时，这种商业模式也有助于提高公众对产后抑郁症的认识和意识，为更多妇女提供健康保障。

（四）在个险的基础上增加医保账户作为保费缴纳新渠道

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险产品以给更多的孕产期女性提供保障为己任，为减少因保费负担过重而放弃投保的情况，保险团队提出了一种新型保费模式，即将产后抑郁症保险与医保账户相链接，创新保费缴费途径，允许投保人用其医保账户中的余额进行保费缴纳，将医保账户中的资金有效利用达到最大。

对于客户来说，此举有助于减轻家庭的经济负担，尤其是对于那些经济拮据的家庭，这一创新使得产后抑郁症保险变得更为可及。对于保险公司来说，可以促进更多客户去购买产后抑郁症保险，提高保险覆盖率。对于行业来说，医保账户与保险保费相挂钩这种新型保险模式有望成为未来医疗保险体系的一部分，推动整个行业更加可持续的发展。

参 考 文 献

[1] 邵珠燕,宗可敬,范清美等.产后抑郁症风险预测模型的系统评价[J].中国循证医学杂志,2023,23(07).

[2] 刘丁玮,马妍,俞淦泉等.中国产后抑郁症检出率的 Meta 分析[J].中国循证医学杂志,2019,19(12):1409-1415.

[3] 李广.市政协委员黄容弟：强化对产后抑郁症的筛查干预[N]. 东莞日报,2023-02-08(A06).

[4] 董秉栋.我国宠物保险增值服务营销价值分析[D].辽宁大学,2023.

[5] Haga SM, Drozd F, Brendryen H,et al.Mamma Mia:A feasibility study of a web-based intervention to reduce the risk of postpartum depression and enhance subjective well-being[J].JMIR Res Protoc,2018:1-9.

[6] 邵婷.微信公众号在产妇产后降低抑郁水平中的应用[J].中国城乡企业卫生,2017,32(01):59-60.

[7] 孙溶梅. 心理健康对家庭商业保险市场参与的影响研究[D].山东大学,2022.

[8] 张忠义.保险公司声誉风险管理的研究与探讨[J].中国保险,2013(12):49-51.

[9] 于津.上海市产后抑郁现况调查[D].复旦大学,2011.

[10] 原晋芳,吕军,秦金梅等.上海市徐汇区产妇产后抑郁发生率及相关影响因素[J].上海预防医学,2022,34(10):965-972.

[11] 李育红,彭碧玲,任带娇等.深圳市福田中心区孕产妇产后抑郁症发病现状及发病因素分析[J].海南医学院学报,2009,15(06):640-642+645.

[12] 周林丽,彭沛,曾兆萍等.新媒体时代医院学科微信公众号宣传策略[J].办公室业务,2022(08):107-109.

[13] 黄晓薇代表全国妇联发出《开展“健康中国——母亲行动”守护家人健康》倡议[J].中国妇运,2019(08):13.

[14] 徐越.妇联向社会力量购买服务研究[D].中共上海市委党校,2019.

[15] 彭阔东,连清琼.影视剧广告植入营销策略分析[J].经济师,2021(12):280-281.

[16] 黄启哲. 热播剧中，什么样的“她思考”“她力量”值得守护与点赞？[N]. 文汇报,2021-07-29(007).

[17] 甘嘉莉，彭丽艳.品牌服饰的微信营销策略研究[J].中国商论，2023(19):086-089.

[18] 毕楷文，孙沛.后疫情时代心理健康不容忽视[EB/OL].(2023-10-13). https://www.sss.tsinghua.edu.cn/info/1074/1884.htm

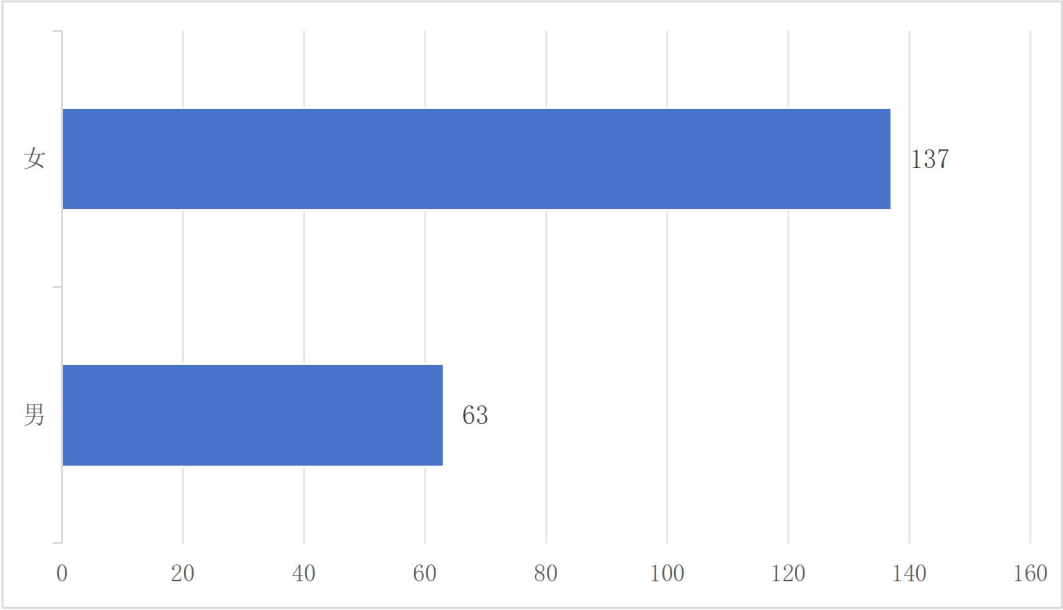
[19] 王珏.XT 公司团险营销策略优化研究[D].中南大学,2022.

[20] 史宝英,杨贺茗.保险数字化营销的思路与对策[J].经济师,2022(06):280-281.

附　录

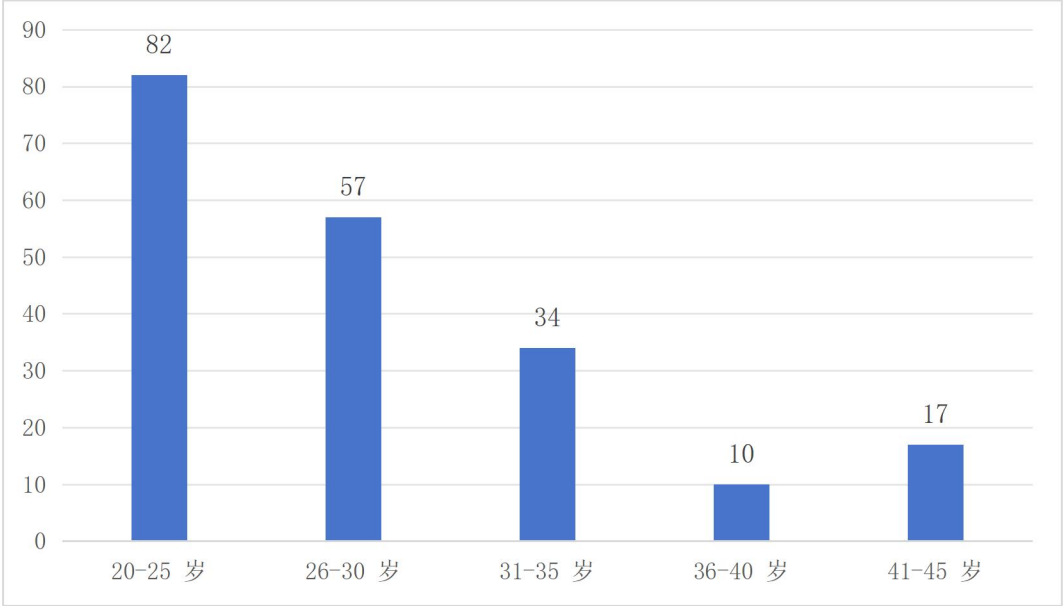
附录 1：产后抑郁症保险市场意愿调查

【第 1 题】您的性别是



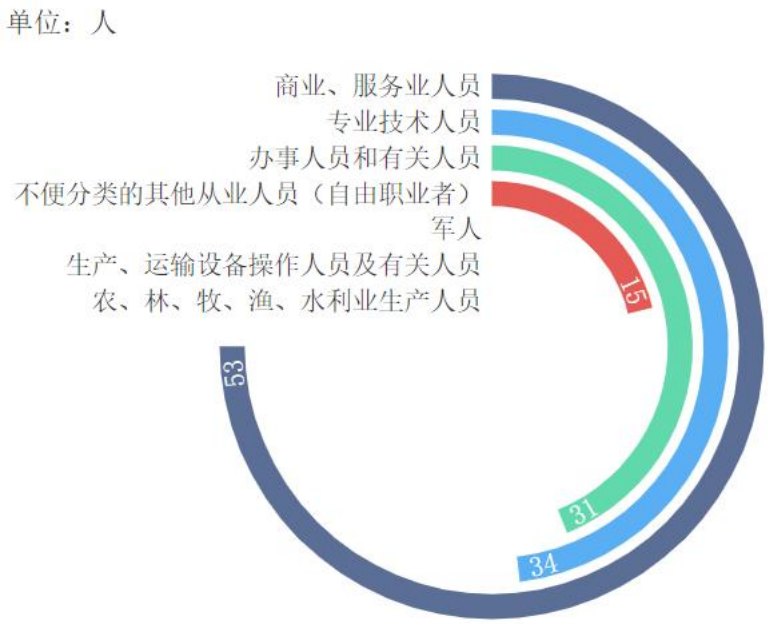
产后抑本次郁症保险市场意愿调查中，着重针对女性发放。

【第 2 题】您的年龄是



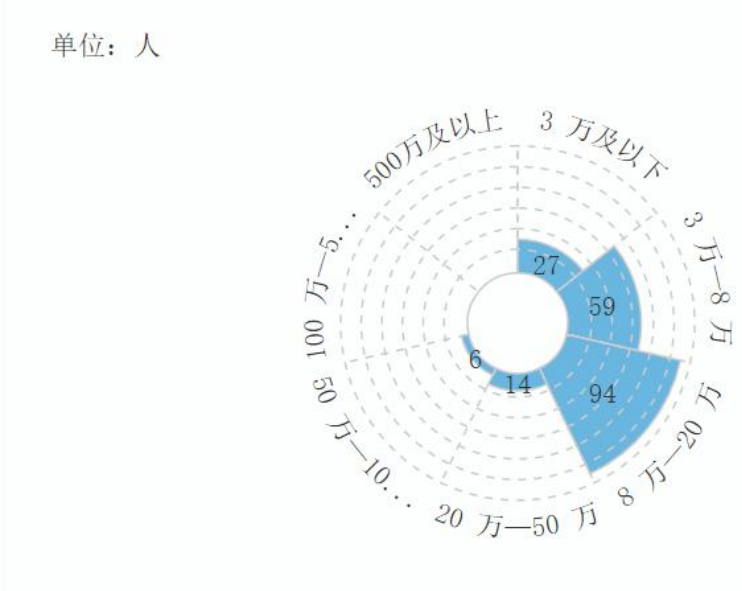
由数据显示，本次问卷的调查对象基本覆盖女性的生育年龄段，同时 20-30 岁是重点调查人群，同时 20-30 岁也是女性生育的最佳年龄段，调查有一定的代表性。

【第 3 题】 您的职业是



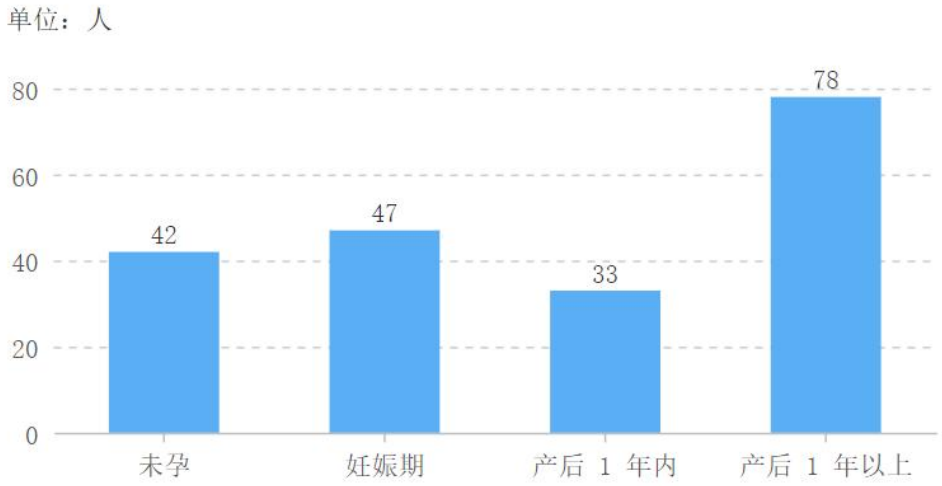
填写问卷的参与者中，以国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人（33.5%）和商业、服务业人员（26.5%）为主要职业群体。覆盖面较广且有一定代表性。

【第 4 题】您的家庭年收入是



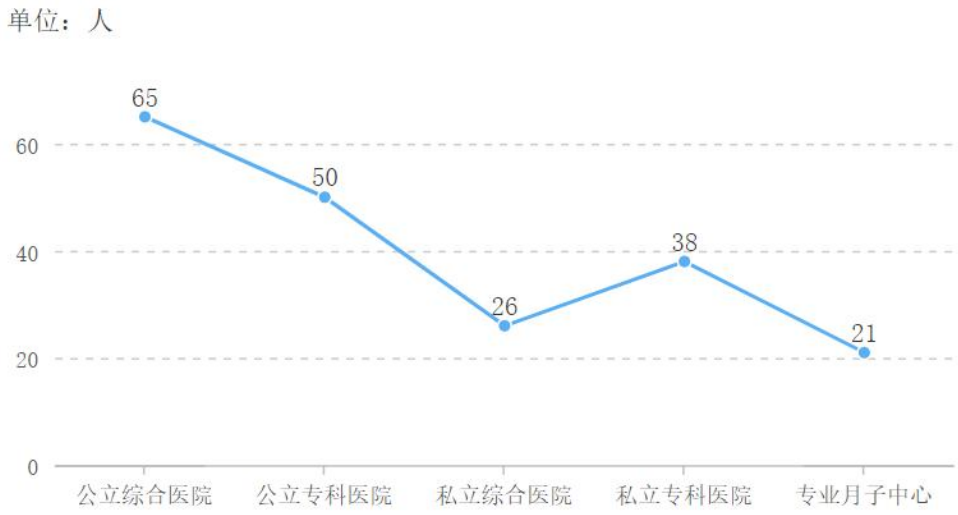
填写问卷的参与者中，家庭年收入以 8 万-20 万之间的居多，其次是 3 万-8 万的收入范围，较高收入范围（20 万及以上）和较低收入范围（3 万及以下）的参与者占比较低。这也与社会人均收入情况相匹配，数据一定程度上能够代表多数人的调查意愿。

【第 5 题】您/您的妻子处于



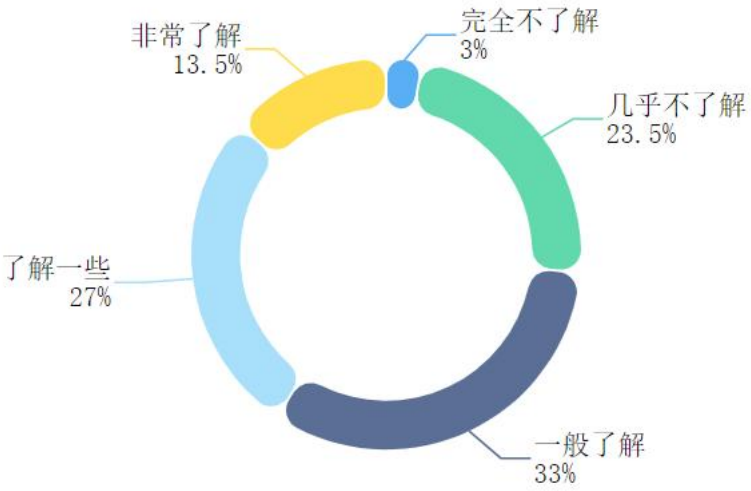
处于妊娠期和产后 1 年内的参与者共 80 位，占调查总人数的 40%。此类人群相对更关注产后的身心健康问题，对产后抑郁症保险的需求可能更为迫切，调查更具代表性。

【第 6 题】您倾向于选择___作为生育建卡/生产地点？



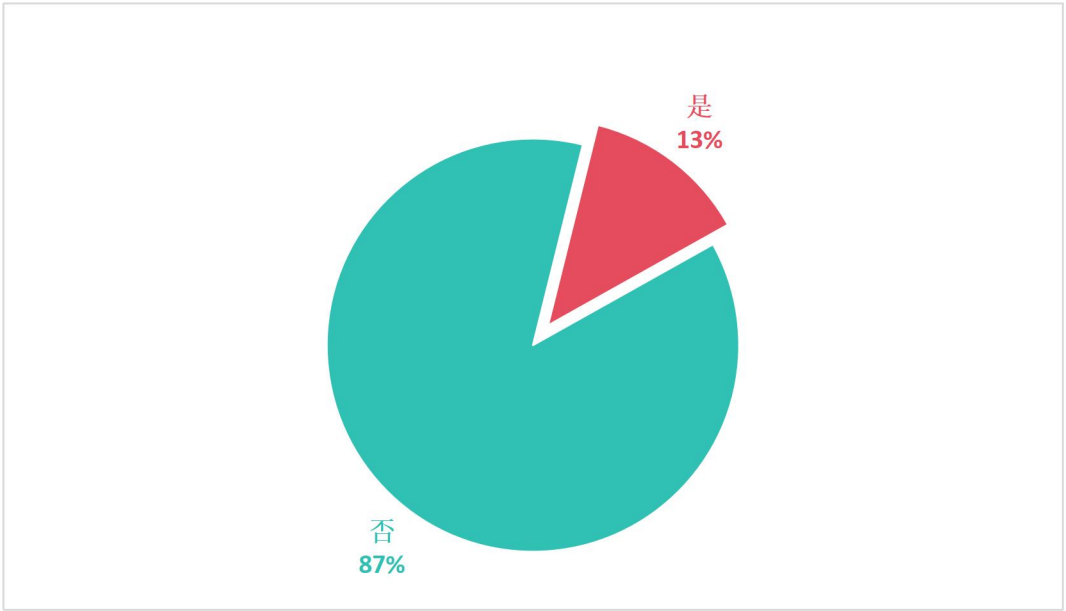
参与填写问卷的对象中，多数人选择公立综合医院作为生育建卡/生产地点，占 32.5%，其次是公立专科医院。同时综合数据可以得知，公立医院的选择占比较高，可能是由于其在医疗资源、专业水平等方面具有更大优势，受到较多人的信任和青睐。数据显示，专业月子中心的选择占比较低，这可能是因为开设的专业月子中心相对价格高、不亲民等原因。

【第 7 题】您是否了解产后抑郁症？



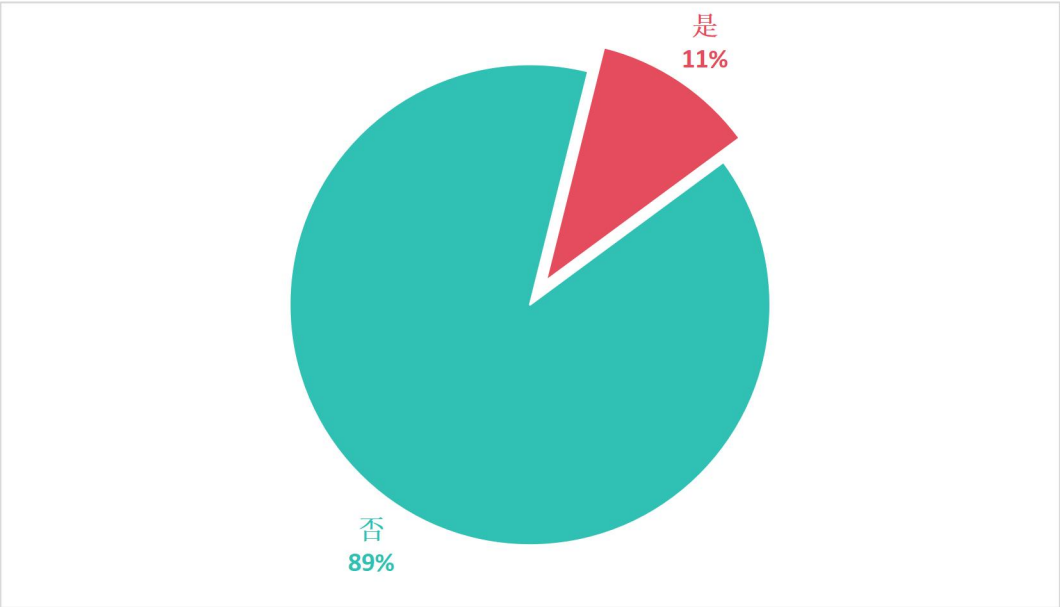
由以上数据可得，参与调查的对象中大部分对产后抑郁症的认知程度仅在一般了解的层面，这意味着对于该问题的关注和传播还需要加强。

【第 8 题】您认为产后抑郁情绪是否为产妇生产的必经过程？



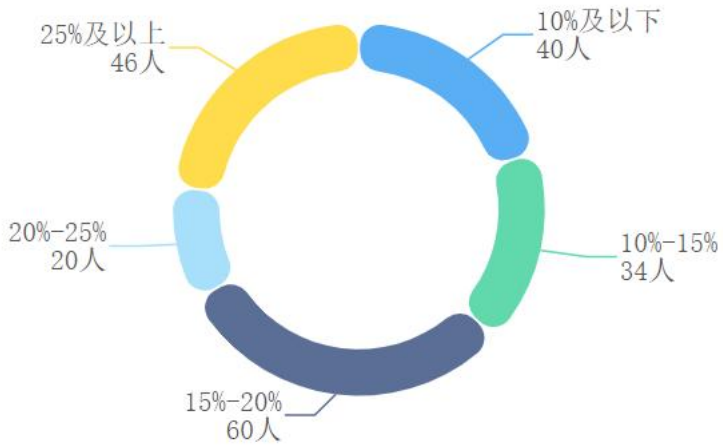
参与填写问卷的对象中，绝大部分人（87%）认为产后抑郁情绪不是产妇生产的必经过程。这体现出人们对于产妇的心理健康关注度并不高，对于产后抑郁症的认知和理解还有待加强，还需要社会提高对产后抑郁症相关知识的宣传和普及。

【第 9 题】您认为产后抑郁症是否为产妇生产的必然结果？



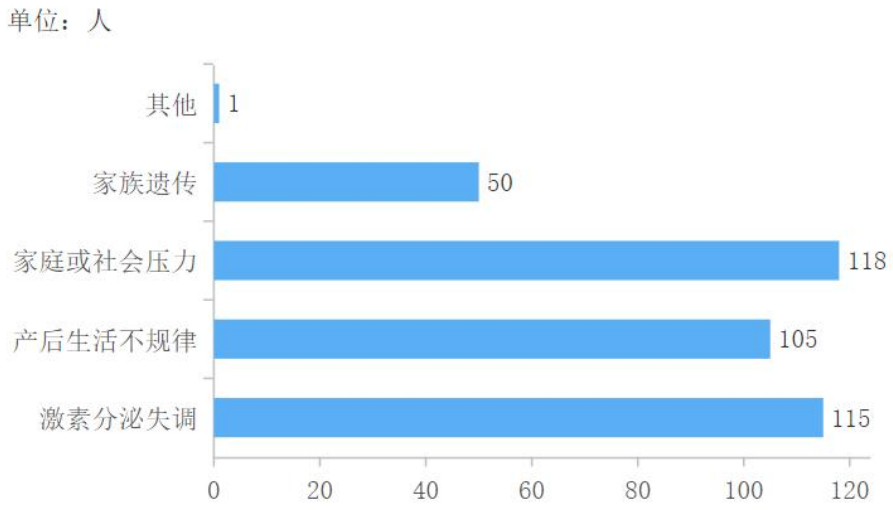
参与填写问卷的对象中，仅有 11%的人认为产后抑郁症是产妇生产的必然结果。此题与上一题都能体现人们对于产妇心理健康以及产后抑郁症的认知和了解还有待加强，需要社会提高对相关知识的宣传和普及。

【第 10 题】您认为目前我国产后抑郁症的确诊率为



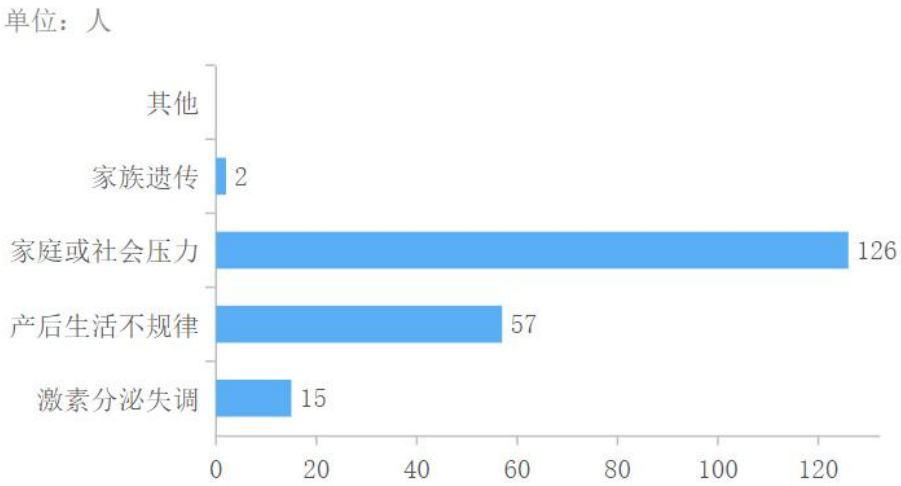
大部分受访者（53%）认为产后抑郁症的确诊率在 15%及以上，其中有 23%的受访者认为确诊率在 25%及以上，这表明人们在综合当下社会心理健康疾病的发展情况后，对于产后抑郁症同样存在一定的担忧，也能反映出产后抑郁症保险在未来市场中的有效性。

【第 11 题】您认为产后抑郁症患病主要原因为　　[多选题]



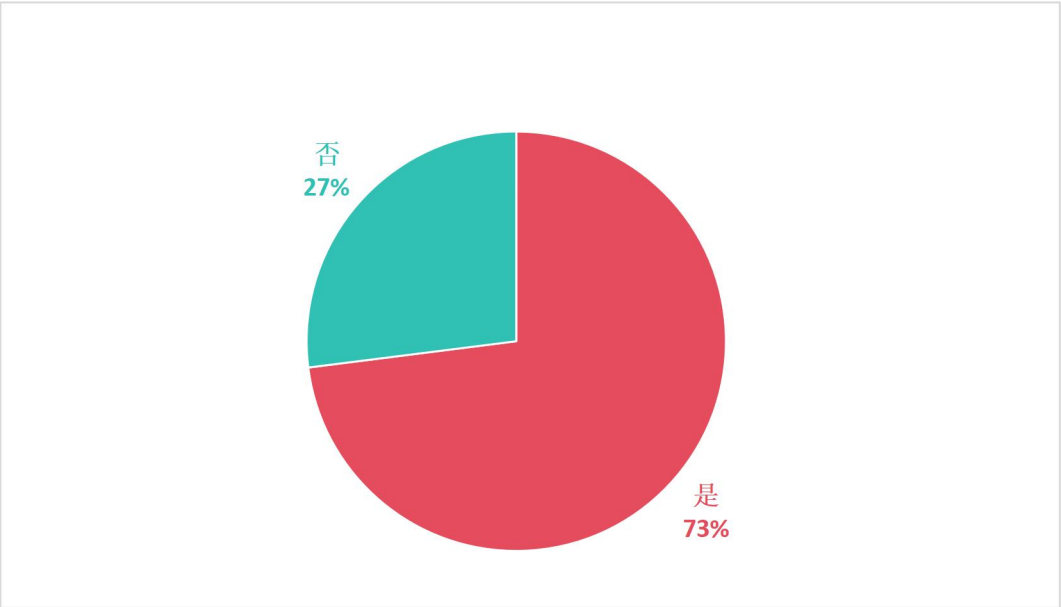
数据显示，家庭或社会压力是受访者认为导致产后抑郁症的主要原因，占比高达 59%，其次是激素分泌失调和产后生活不规律。家族遗传因素的影响相对较低。表明大家对产后抑郁症这一心理疾病也有一定的了解。

【第 12 题】 在 11 题中，您认为最主要的原因为上述的



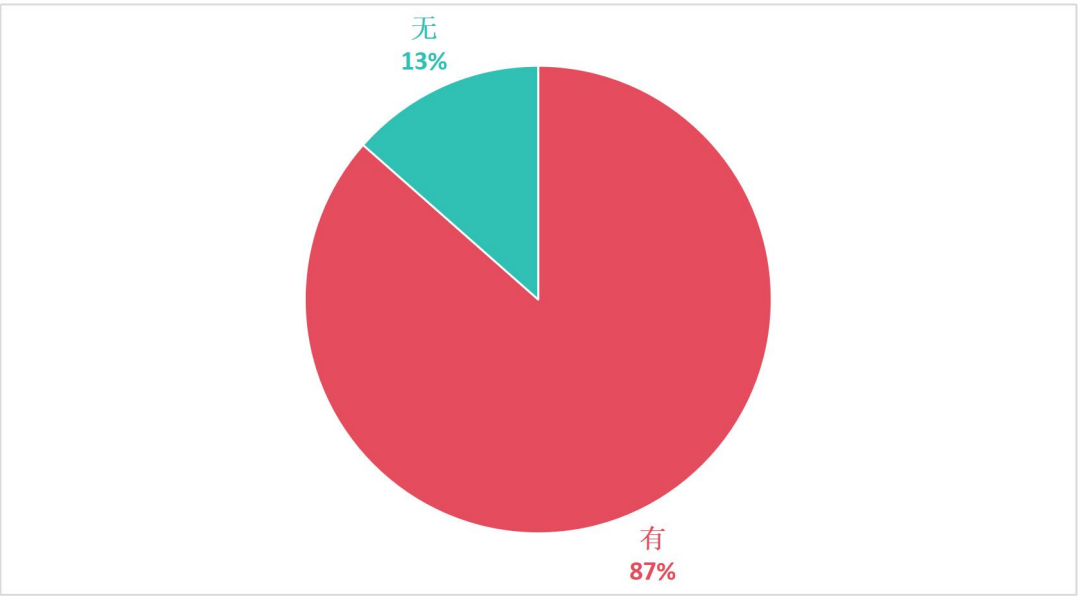
过半数的被调查者认为家庭或社会压力是导致产后抑郁症的最主要原因，而激素分泌失调和产后生活不规律也占有一定比例。这表明多数人认为外部因素（如家庭或社会压力）是引起产后抑郁症的主要原因，但也不排除其他因素（如生理变化）的影响，这对于本保险更好地了解潜在客户的需求和关注点，以便更好地设计和定位保险产品有重要意义。

【第 13 题】当您/您的妻子出现疑似产后抑郁症的症状，您是否会去医院就诊？



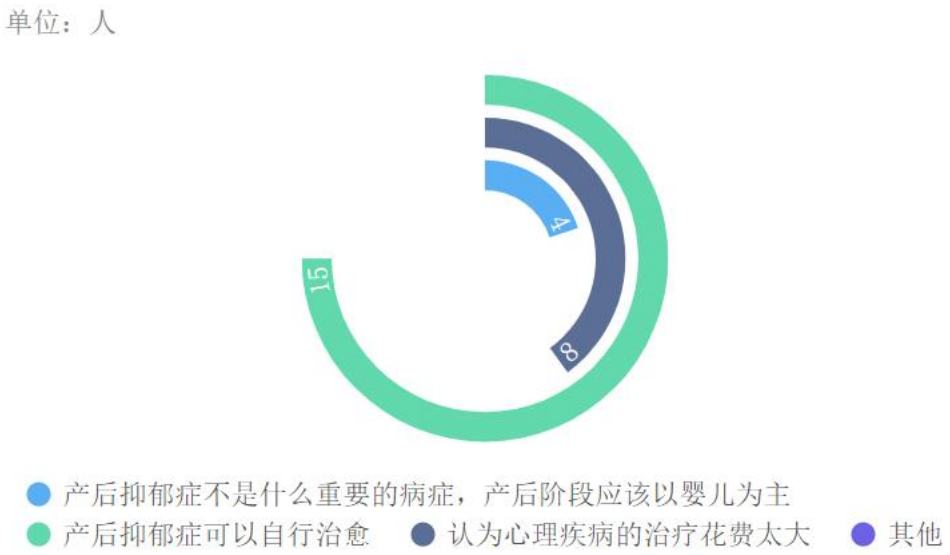
大多数受访者在妻子出现疑似产后抑郁症症状时会选择去医院就诊，这既体现了受访者重视家庭健康的态度，也表明受访者认识到专业医疗帮助对于产后抑郁症的治疗和康复的重要性。这也能体现出公众普遍具有“担心患病”的生活理念，产后抑郁症也不例外，这也为产后抑郁症保险的推广提供了较为广阔的前景。

【第 14 题】若您/您的妻子已经确诊产后抑郁症，您是否认为有治疗的必要性？



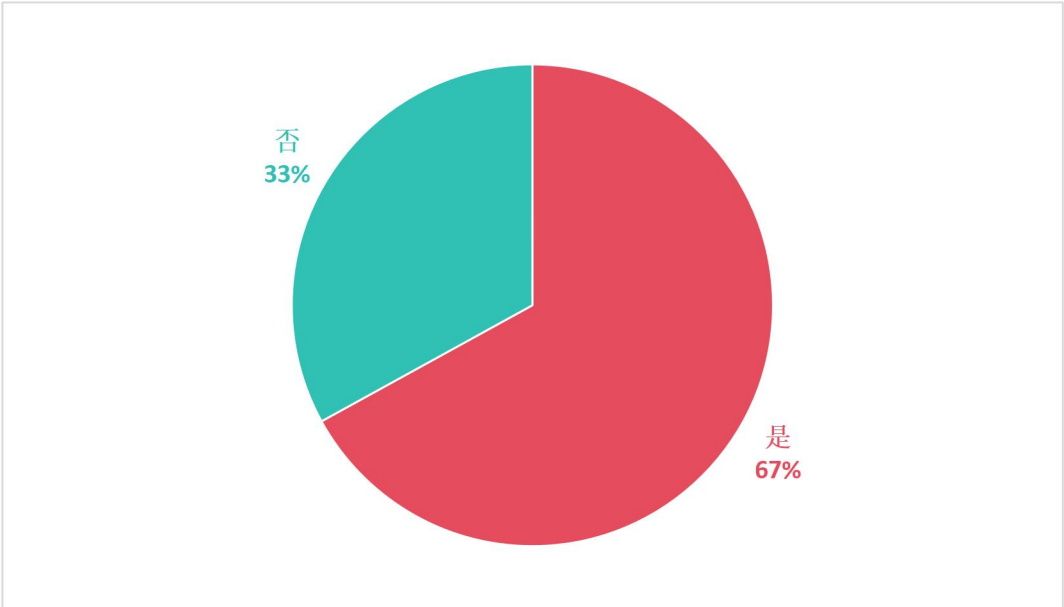
绝大多数受访者（86.5%）在妻子确诊产后抑郁症后认为有治疗的必要性，这说明受访者对于家属患病的重视程度高，会选择投入时间金钱去治疗，这也体现产后抑郁症保险具有广阔的客户市场。

【第 15 题】 您认为产后抑郁症没有治疗的必要的原因是



由调查数据可知，在认为产后抑郁症没有治疗必要的受访者中，过半数人是认为产后抑郁症可以自行治愈，还有一部分受访者是出于对治疗费用的顾虑，极少数人对其表示并不重视。由此可以看出人们对于产后抑郁症的理解还存在一定的误区，同时对于心理疾病的治疗也有一定的担心程度。这表明社会更应该加强对产后抑郁症的宣传力度，并完善社会相关心理疾病的医疗保障体系，让人们重新认识产后抑郁症及类似的心理疾病。

【第 16 题】 您是否会考虑购买产后抑郁症保险?



过半数的被访者（67%）对购买产后抑郁症保险表现出了积极的态度。这可能反映了社会对于关注女性健康、特别是产后心理健康的重视程度，也意味着人

们逐步提高对于产后抑郁症相关风险的认知程度。然而，仍有相当一部分被访者（33%）对此持否定态度，这提示团队可以借助宣传和推广的力量将这一部分潜在客户转化为现实客户。

【第 17 题】您不考虑购买产后抑郁症保险的原因是



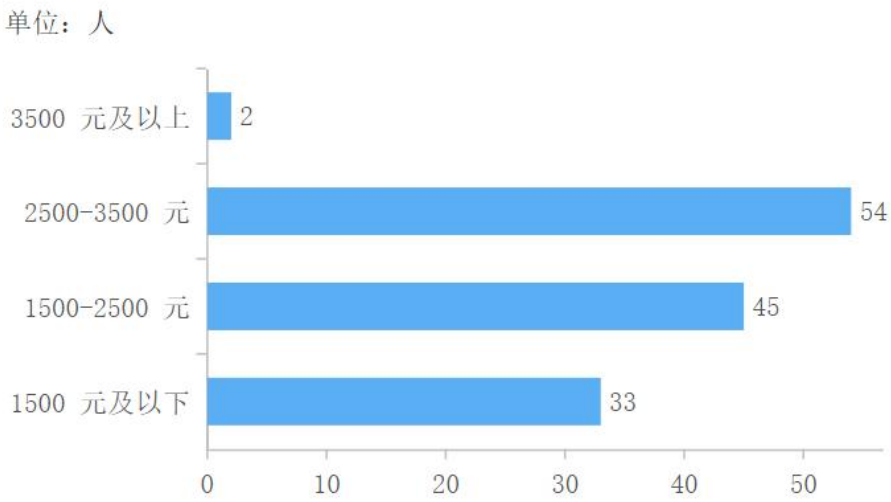
通过以上占比数据，我们可以总结得知在不考虑购买保险的受访者当中，一部分人认为该类疾病的影响可以规避，还有一部分人觉得自己/妻子不会遇到产后抑郁风险并且不符合自身需要以及即便确诊获得保险金，保险也无法补偿疾病所带来的损失或伤害，这表明部分人购买保险转移风险的意识并不强烈，社会对于保险产品的认可和信赖度还有一定的提升空间。这意味着保险行业仍需要抓住社会民生热点问题，细化行业规范，提高在人民心中的认可度。

【第 18 题】您会考虑购买产后抑郁症保险的原因



通过以上占比数据，我们可以看出希望能够享受产后抑郁症保险配套的优质服务这一选项占比较高（60.78%），其次是希望在确诊后能得到相应的经济补偿（17.65%）。这表明人们对于保险产品的意愿不再局限于经济补偿层面，更希望一举两得，在转移风险的同时享受配套服务，获得更好地治疗体验。这也为后续产后抑郁症保险产品的设计提供一定思路。

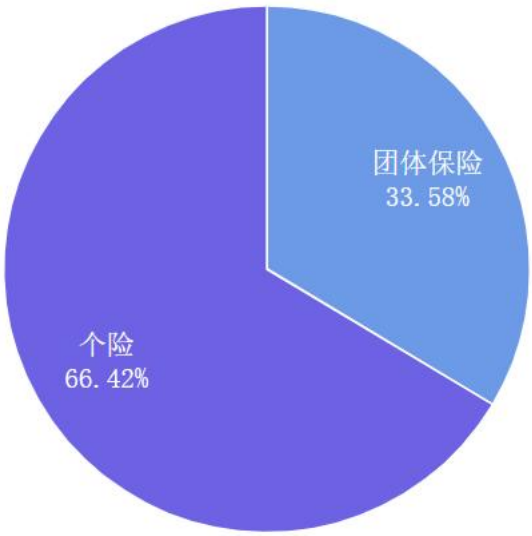
【第 19 题】在目前保险市场，年龄为三十岁的孕期女性购买相关保险的保费支出约为 1500 元/年-3500 元/年。针对产后抑郁症保险，您的理想保费为：



综合数据显示，参与者对产后抑郁症保险的理想保费在 1500 元至 3500 元之间。具体来看，40.30%的受访者倾向于支付 2500-3500 元，33.58%的受访者选择支付 1500-2500 元，24.63%的受访者认为 1500 元及以下是他们的理想保费支出，

而只有极少数（约 1.49%）的受访者愿意支付 3500 元及以上。整体来看，保费偏向于中等水平，在 1500 元至 3500 元范围内呈现较为均衡的分布，符合市场需求的多样性和广泛性。

【第 20 题】如果需要购买产后抑郁症保险，您更倾向于购买价格低普适化的团体保险，还是购买价格高个性化定制的个人保险？



大部分受访者（约 66.42%）更倾向于选择购买价格较高且个性化定制的个人保险，认为这种类型的保险产品更符合他们的需求和偏好。另外，约 33.58%的受访者倾向于购买价格低且普适化的团体保险。整体来看，个人保险在调查中占据了较大比例，显示出受访者更偏向于选择个性化定制的保险产品，这可能与社会越来越尊重差异化和多样性的氛围有关。团体保险虽然有一定比例支持者，但整体而言个人保险的市场需求更为广阔。这为本产后抑郁症保险的发展制定提供了思路。

【第 21 题】产后抑郁症保险的保险期限为投保日期至产后 365 日 24 时止。在此期间，请根据您对下列服务的需要程度进行打分（一点也不需要为 1 分，不太需要为 2 分，一般为 3 分，有点需要为 4 分，非常需要为 5 分）

服务类别	平均值
孕前的专业医疗咨询服务	3.75
产检陪同服务	3.58

心理疏导服务	4.17
孕妇营养咨询服务	3.83
产教中心推荐服务	3.67
生产中心推荐服务	3.75
产后修复医院推荐服务	3.83
疫苗接种提醒服务	4.08
母婴营养咨询服务	4
产妇社群建立服务	4
新手父母指导服务	4.42
新生儿趣味启蒙服务	4.25
新生儿全周期疫苗服务	4.25
	平均：3.97

由调查数据可知，新手父母指导服务、新生儿趣味启蒙服务和新生儿全周期疫苗服务的平均评分位列前三，分别为 4.42、4.25 和 4.25，说明在产后抑郁症保险中，参与者对针对新生儿和新手父母的服务需求较为突出。心理疏导服务和疫苗接种提醒服务也得到了较高的评分，显示出参与者对心理支持和健康管理方面的需求较大。综合来看，参与者对这些服务的需求程度普遍较高，这为产后抑郁症保险产品中服务方面的具体设计提供了有力的参考依据和指导。

附录 2：“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症团体保险条款

1 关于本合同

1.1 合同构成

“蓝天妈咪护盾”产后抑郁症保险合同(以下简称“本合同”)由保险条款、保险单或其他保险凭证、所附的投保单及相关文件、有关的声明、批注单及其他约定书构成。

若上述构成本合同的文件正本需留本公司存档，则其复印件或电子影印件的效力与正本相同。若复印件或电子影印件的内容与正本不同，则以正本为准。

1.2 投保范围

机关、企业、事业单位、社会团体及其他不以购买保险为目的而组成的团体可为其团体成员向本公司投保本保险。投保团体属于其他不以购买保险为目的而组成的团体的，投保人可以是特定团体中的自然人。

除有特别约定外，参保人员须符合的基本条件为年龄范围在20（含）周岁(见释义，下同)-45（含）周岁无心理疾病病史、家族史的女性职工。

1.3 保险期间

本合同为**可连续续保**合同。本合同的保险期间为**一年**。

1.4 合同成立

投保人提出保险申请、本公司同意承保，本合同成立。

合同生效日期在保险单上载明。

1.5 等待期

本合同中各项保险责任的等待期，由投保人和保险人双方在订立保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。其中，等待期是指自保险期间开始之日起，由保险人与投保人约定的、虽然发生了保险事故但是保险人不承担保险责任的一段时间。

2 本合同提供的保障

2.1 保险责任

在投保人依约交纳本合同对应保险费的情况下，保险人同意承保以下

的各项保险责任：

2.1.1 产后抑郁症门诊医疗保险金

在保险期间内，被保险人在等待期届满后在指定医院(见释义，下同)确诊罹患本合同约定的产后抑郁症(见释义,下同)，对于被保险人在指定医院的普通部中为了治疗上述产后抑郁症而实际支出的、合理且必要(见释义，下同)的**门诊医疗费用**，保险人在**扣除本项保险责任约定的免赔额**后，按照本项保险责任约定的给付比例，在本项保险责任约定的保险金额内支付产后抑郁症门诊医疗保险金。

2.1.2 产后抑郁症住院医疗保险金

在保险期间内，被保险人在等待期届满后在指定医院(见释义，下同)确诊罹患本合同约定的产后抑郁症(见释义,下同)，对于被保险人在指定医院的普通部中为了治疗上述产后抑郁症而实际支出的、合理且必要(见释义，下同)的**住院**(见释义，下同)**医疗费用**，保险人在**扣除本项保险责任约定的免赔额**后，按照本项保险责任约定的给付比例，在本项保险责任约定的保险金额内支付产后抑郁症住院医疗保险金。

2.2 补偿原则

对于第2.1.1项“产后抑郁症门诊医疗保险金”和第2.1.2项“产后抑郁症住院医疗保险金”两项保险责任，适用**医疗费用补偿原则**。若被保险人已从其他途径(包括但不限于基本医疗保险(见释义，下同)、政府主办补充医疗(见释义,下同)、公费医疗(见释义，下同)、工作单位、保险人在内的任何商业保险机构，以及依法承担侵权损害赔偿责任的第三方等)获得医疗费用补偿，则保险人仅对被保险人实际发生的医疗费用在扣除其所获医疗费用补偿后的余额按照本合同的约定进行赔偿。即意味着包括本合同在内的各种途径所给付的所有补偿金额之和**不得超过被保险人实际发生的医疗费用**。

2.3 给付标准

对于第2.1.1项“产后抑郁症门诊医疗保险金”和第2.1.2项“产后抑郁症住院医疗保险金”两项保险责任，针对被保险人使用了基本医疗保险结算或者未使用基本医疗保险结算的两种情形，投保人和保险人可分别约

定不同的免赔额和给付比例，并在保险合同中载明。

除另有约定外，基本医疗保险以被保险人的参保地的相关规定及政策结算为准。

2.4 责任免除

2.4.1 通用责任免除

因下列情形之一导致被保险人确诊罹患本合同约定的产后抑郁症，本公司**不承担**给付保险金的责任：

（1）投保人对被保险人的故意伤害、故意杀害；

（2）被保险人曾患有心理疾病及精神疾病的；

（3）被保险人违反《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》条款；

（4）被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施、自杀(但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外)、故意自伤；

（5）等待期内被保险人确诊本合同约定的产后抑郁症；

（6）被保险人在本合同约定的指定医院的普通部之外产生的任何费用；

（7）被保险人斗殴、酗酒、主动吸食或注射毒品；

（8）被保险人因受国家管制药物的影响或未遵医嘱服用、涂用、注射药物；

（9）各种医疗鉴定、医疗意外和医疗事故；

（10）被保险人因产后抑郁症之外的原因身故；

（11）被保险人不符合入院标准、挂床住院或者应当出院但拒不出院（从医院确定出院之日起发生的一切医疗费用）；

（12）被保险人因患产后抑郁症所引起的财产损失；

（13）被保险人因患产后抑郁症对第三者造成的人身伤亡和财产损失；

（14）战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；

（15）核爆炸、核辐射或核污染

2.4.2 其他责任免除条款

除本条款第2.4项“责任免除”外，本合同中还有一些免除保险人责任的条款，详见本条款的第1项“保险责任”、第2项“补偿原则”、第3项“给付标准”、第1.5项“等待期”、第3项“保险金额、免赔额和给付比例”、

第4项“投保人的义务”、第5.3项“保险金申请”、第6.1项“投保人解除合同”、及第7项“释义”中部分以黑体字加粗标示的内容。

2.5 增值服务

对每一位参保人员，本公司在合同有效期间履行以下服务：

3 保险金额、免赔额和给付比例

3.1 保险金额

本合同中各项保险责任的保险金额，由投保人与保险人双方在订立保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。保险金额，是指在保险期间内，属于保险责任范围内的、应由保险人承担给付保险金责任的最高限额。

3.2 免赔额

本合同中各项保险责任的免赔额，由投保人与保险人双方在订立保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。除另有约定外，本合同的免赔额为次免赔额。

免赔额，是指在保险期间内被保险人发生保险责任范围内的费用中须首先由被保险人自行负担、且保险合同不予赔付的金额。其中，基本医疗保险、政府主办补充医疗和公费医疗已经报销的部分，不能计入免赔额;除基本医疗保险、政府主办补充医疗和公费医疗以外的其他途径已获得医疗费用补偿的部分，可计入免赔额。

3.3 给付比例

本合同中各项保险责任的给付比例，由投保人与保险人双方在订立保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。给付比例，是指保险人在扣除免赔额后在保险责任范围内给付的剩余部分医疗费用的百分比。

4 投保人的义务

4.1 明确说明与如实告知

订立本合同时，本公司应向投保人说明本合同的内容。

对保险条款中免除本公司责任的条款，本公司在订立合同时应当在投保单、 保险单或其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款

的内 容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的， 该条款不产生效力。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本合同或终止对该被保险人的保险责任。

如果投保人故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前或终止对该被保险人的保险责任前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前或终止对该被保险人的保险责任前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，本公司不得解除合同或终止对该被保险人的保险责任；发生保险事故的，本公司承担给付保 险金的责任。

4.2 本公司合同解除权的限制

本条款第4.1项“明确说明与如实告知”规定的合同解除权在以下情形下不得行使，发生保险事故的，本公司承担给付保险金责任：

（1）本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的；

（2）自本公司知道有解除事由之日起，**超过30日的**。

4.3 保险费的交纳

本合同保险费的交纳方式为**趸缴**，即一次交清。

5 如何申请领取保险金

5.1 受益人

除第2.1.3项“身故保险金”外，本合同的各项保险金受益人均为**被保险人本人**。

就第2.1.3项“身故保险金”，投保人或者被保险人可以指定一人或多人为身故保险金受益人。

身故保险金受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；若没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。投保人或者被保险人可以变更身故保险金受益人并书面通知本公司。本公司收到变更受益人的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。

投保人在指定和变更身故保险金受益人时，必须经过被保险人同意。

被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由本公司依照《中华人民共和国继承法》的规定履行给付保险金的义务：

（1）没有指定受益人， 或者受益人指定不明无法确定的；

（2）受益人先于被保险人身故， 没有其他受益人的；

（3）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。

受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故顺序的，推定受益人身故在先。受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

5.2 保险事故通知

投保人、被保险人或受益人知道保险事故后应当在 **10 日内**通知本公司。

如果投保人、被保险人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，本公司对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但本公司通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响本公司确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

5.3 保险金申请

保险金申请人(见释义,下同)向保险人申请给付保险金时,应当以**书面形式**提供以下证明和资料。保险金申请人因特殊原因不能提供以下材料的,应提供其他合法有效的材料。保险金申请人**未能提供有关材料**,导致保险人无法核实的,保险人对无法核实部分**不承担**给付保险金的责任。

(1)保险金给付申请(书)。

(2)保险金申请人、被保险人的有效身份证明。

(3)需提供(如涉及):孕妇(健康/保健)手册、孕期检查报告、分娩的出院记录。

(4) 需提供(如涉及) :新生儿的医学出生证明。

(5)就诊指定医院出具的支持索赔的全部账单、证明、信息和证据，包括但不限于病历资料、医学诊断书、处方、病理检查、化验检查报告、出院小结、医疗费用原始单据、费用明细单据等。如被保险人在基本医疗保险经办机构、其他保险人或其他单位已经获得部分医疗费用赔偿，医疗费用收据原件已被赔付或报销单位留存，保险金申请人在提出索赔申请时，应向保险人提交医疗费用收据财务分割单或在医疗费用收据复印件.上注明已赔付金额，并加盖赔付单位的财务章。

(6)保险金申请人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

(7) 若保险金申请人委托他人申请的，还应提供授权委托书原件、委托人和受托人的身份证明等相关证明文件;受益人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,由其监护人代为申领保险金，并需要提供监护人的身份证明等资料。

以上证明和资料不完整的，本公司将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

5.4 保险金的给付

保险人收到保险金申请人的给付保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的，应当在**三十日内**作出核定，但保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知保险金申请人;对属于保险责任的，在与保险金申请人达成给付保险金的协议后**十日内**，履行给付保险金义务。保险合同对给付保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行给付保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起**三日内**向保险金申请人发出拒绝给付保险金通知书，并说明理由。

保险人自收到给付保险金的请求和有关证明、资料之日起**六十日内**，对其给付的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定给付的数额后，应当支付相应的差额。

5.5 诉讼时效

受益人向本公司请求给付保险金的诉讼时效期间为**二年**，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。

6 投保人需要关注的其他事项

6.1 投保人解除合同

除本合同另有约定外，本合同成立后，投保人**不得要求解除本合同**。

6.2 地址变更

为了保障投保人的合法权益，投保人的住所或通讯地址变更时，请及时以书面形式通知本公司。若投保人未以书面形式通知本公司，本公司按本合同载明的最后住所或通讯地址发送的有关通知，均视为已送达给投保人。

6.3 争议处理

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向中国境内有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中国法律。

6.4 被保险人的变动

6.4.1 被保险人增加

投保人需要增加被保险人的，应书面通知本公司，并提供相应的证明文件。本公司审核同意并收到相应保险费的次日零时起，开始对新增的被保险人承 担保险责任。

6.4.2 被保险人减少

投保人需要减少被保险人的，应书面通知本公司，并提供相应的证明文件。除另有约定外，本公司对其所承担的保险责任自通知到达时终止。本公司向投保人退还相应的现金价值。主被保险人退出本保险的，其对应的连带被保 险人也同时退出本保险。本合同被保险人人数**少于3人**时，本公司有权解除本合同，并向投保人退还 本合同保险单的现金价值。

7 释义

本合同涉及下列术语时，适用以下释义:

7.1 周岁

指按合法的身份证明文件中记载的出生日期计算的年龄,自出生之日起为零周岁，每经过一年增加一岁，不足一年的不计。

7.2 本公司认指本公司指定的医院

指投保人与保险人约定的定点医院范围，并应在保险合同中载明。

若双方没有约定并载明的，则指在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)经中华人民共和国国家卫生健康行政部门审核认定的二级或二级以上的公立医院，该医院必须具有系统的、充分的诊断设备，全套外科手术设备及能够提供24小时的医疗与护理服务的能力或资质，且不包括如下的医疗机构、科室或医疗服务:

（1）特需医疗、外宾医疗、干部病房、联合病房、国际医疗中心、VIP部、联合医院或相类似的机构或科室;

（2）诊所、康复中心、家庭病床、护理机构;

（3）休养、戒酒、戒毒中心。

7.3 产后抑郁症

女性于产褥期出现明显的抑郁症状或典型的抑郁发作,与产后心绪不宁和产后精神病同属产褥期精神综合征。

7.4 合理且必要

指符合以下两个条件:

(1)符合通常惯例

指与接受医疗服务所在地通行治疗规范、通行治疗方法、平均医疗费用价格水平一致的费用。

对是否符合通常惯例，由保险人根据客观、审慎的原则进行审核;如果被保险人对审核结果有不同意见,可由双方认同的权威医学机构或者权威医学专家进行审核鉴定。

(2)医学必要

指被保险人接受治疗或服务、使用器械或服用药品符合以下条件:

a.医师处方要求且对治疗被保险人疾病或伤害合适且必需;

b.在范围、持续期、强度、护理.上不超过为被保险人提供安全、恰当、合适的

诊断或治疗所需的水平;

c.与接受治疗地普遍的医疗专业实践标准一致;

d.非主要为了个人舒适或为了被保险人父母、家庭、医师或其他医疗提供方的方便;

e.非病人学术教育或职业培训的一部分或与之相关;

f.非试验性或研究性。

7.5 住院

指被保险人以治疗疾病为目的，正式办理入住院手续进行治疗的行为，不包括入住门急诊观察室、家庭病床、联合病房、挂床住院等不合理住院以及康复、休养、疗养、身体检查和健康护理等非治疗性行为。

挂床住院指办理正式住院手续的被保险人，在住院期间每日非24小时在床、在院，包括在住院期间连续若干日无任何治疗，只发生护理费、诊疗费、床位费的情况。

7.6 基本医疗保险

指《中华人民共和国社会保险法》中所规定的基本医疗保险，包括职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险等政府举办的基本医疗保障项目。

7.7 政府主办补充医疗

指城乡居民大病保险、城镇职工大额医疗保险、城镇居民大额医疗保险等由政府主办对基本医疗保险进行补充的医疗保障项目,大额医疗保险在各地的具体名称会有所不同，以投保所在地政府主管部门]规定的名称为准。

7.8 公费医疗

指国家为保障国家工作人员而实行的、通过医疗卫生部门按规定向享受人员提供免费医疗及预防服务的一项社保制度。

7.9 酗酒

指酒精摄入过量。长期过量饮酒导致身体脏器严重损害，或一次大量饮酒导致急性酒精中毒或自制力丧失造成自身伤害、斗殴肇事或交通肇事。酒精摄入过量由医疗机构或公安部门判定。

7.10 毒品

指中华人民共和国刑法规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

7.11 战争

指国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间为了一定的政治、经济目的而进行的武装斗争，以政府宣布为准。

7.12 军事冲突

指国家或民族之间在一定范围内的武装对抗，以政府宣布为准。

7.13 暴乱

指破坏社会秩序的武装骚乱，以政府宣布为准。

7.14 保险金申请人

指受益人或被保险人的继承人或依法享有保险金请求权的其他自然人。

（条款全文结束）